



BUKU PANDUAN TUGAS AKHIR

FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)

UNIVERSITAS DR. SOEBANDI
YAYASAN JEMBER INTERNATIONAL SCHOOL (JIS)

BUKU PANDUAN TUGAS AKHIR FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

TIM PENYUSUN

Ketua Komite:

Kustin, S.KM., M.Kes

Sekretaris Komite:

Yuni Handayani, S.ST., M.Kes

Anggota Komite

1. Apt Lindawati Setyaningrum, M.Farm
2. Apt. Ayu Angger Putri M.Sholeh., M.Farm
3. Apt. Nafisah Isnawati, M.Si
4. Dr. Yugi Hari Candra Purnama, M.Si
5. Ns. Zidni Nuris Yuhbaba, S.Kep., M.Kep
6. Ns. Wike Rosalini, S.Kep., M.Kes
7. Ns. Roby Aji, S.Kep., M.Kep
8. Ns. Rida Darotin, S.Kep., M.Kep
9. Ns. Ainul Hidayati, S.Kep., M.K.M
10. Yuningsih, S.ST., M.Keb
11. Ernawati Anggraeni, S.ST., M.Kes
12. Hartalina Mufidah, S.Si., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

Buku Panduan Tugas Akhir disahkan pada :
Hari Selasa, 01 Oktober 2024

**Fakultas Ilmu Kesehatan,
Dekan**



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIK. 19891219 201309 2 036

**Komite Skripsi,
Ketua**



Kustln, S.KM., M.Kes
NIK. 19841110 201108 2 009

Mengetahui,

**Universitas dr. Soebandi
Rektor,**




Andri Eka Pranata, SST, S. Kep, Ns, M.Kes
NIK. 19860922 201201 1 019

**Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Wakil Rektor I,**



Feri Ekaprasetia, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NIK. 19920122 201609 1 127



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,
E_mail : fikes@uds.ac.id Website: <http://fikes.uds.ac.id>

KEPUTUSAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

Nomor : 5226/FIKES-UDS/K/X/2024

Tentang

PENETAPAN BUKU PANDUAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

- Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan Tugas Akhir Mahasiswa (SKRIPSI) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi, dipandang perlu disusun suatu Buku Panduan yang menjadi dasar standar Akademik Tugas Akhir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Dekan tentang Penetapan Buku Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 291/E/O/2021 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dr. Soebandi Di Kabupaten Jember Menjadi Universitas dr. Soebandi Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Yang Diselenggarakan Oleh yayasan Pendidikan Jember International School;
9. Statuta Universitas dr. Soebandi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI TENTANG PENETAPAN BUKU PANDUAN SKRIPSI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI TAHUN AKADEMIK 2024/2025



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,
E_mail : fikes@uds.ac.id Website: <http://fikes.uds.ac.id>

- KESATU** : Buku Panduan Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi Tahun Akademik 2024/2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini;
- KEDUA** : Buku Panduan Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi Tahun Akademik 2024/2025 di peruntukkan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan yang sedang menempuh Skripsi;
- KETIGA** : Hal - hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur dikemudian hari;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 07 Oktober 2024

Universitas dr. Soebandi
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

Ai Nur Zannah, S.ST, M. Keb
NIK. 19891219 201309 2 038

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Warek Universitas dr. Soebandi
2. Ketua Prodi Profesi Kebidanan
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Tim Penyusun	ii
Halaman Pengesahan	iii
SK Penetapan	iv
Daftar Isi	v
BAB 1 Pendahuluan.....	1
BAB 2 Ketentuan Umum Penulisan Tugas Akhir.....	9
BAB 3 Prosedur Penyusunan Tugas Akhir.....	13
BAB 4 Sistematika Penulisan Proposal.....	22
BAB 5 Sistematika Penulisan Skripsi.....	37
BAB 6 Format Penulisan Akhir.....	40
BAB 7 Format Penulisan Skripsi.....	41
BAB 8 Pelaksanaan Ujian Skripsi.....	55
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan karya ilmiah merupakan salah satu ciri pokok dari kegiatan perguruan tinggi. Karya ilmiah adalah karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah, dan mengikuti pedoman atau dikerjakan sesuai konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan (Saukah dkk, 2017; Hermawan, 2019).

Tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian maupun kajian ilmiah yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa sesuai dengan jenjang program pendidikan tinggi sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020. Universitas dr. Soebandi mewajibkan mahasiswa pada Program Sarjana menyusun skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian studi.

Penulisan tugas akhir didasari pemikiran bahwa pelaksanaan karya tulis ilmiah yang dimulai dengan usulan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data serta penuangan dalam bentuk laporan ilmiah merupakan proses pembelajaran yang berguna dalam melatih mahasiswa untuk mampu membentuk pemikirannya. Penyusunan tugas akhir dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan dari dosen pembimbing (Mansyur, 2018).

Sebagaimana bentuk karya ilmiah lainnya, skripsi harus memenuhi syarat keilmuan seperti penalaran logika, sistematika, prosedur, dan metode baku serta menggunakan ragam bahasa ilmiah sehingga diperlukan suatu pedoman yang disebut dengan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Buku pedoman ini diterbitkan sebagai pedoman yang wajib diikuti oleh mahasiswa dalam menempuh tugas akhir serta pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar pelaksanaan tugas akhir dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Buku pedoman ini juga disusun dengan harapan dapat menyeragamkan tata tulis tugas akhir dan memperkaya kemampuan mahasiswa, khususnya dalam merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan

di Universitas dr. Soebandi sesuai keahlian/bidang studi tertentu dan berlandaskan konsep dan sikap ilmiah.

1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa

Penyusunan dan penerbitan buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Sarana informasi dan komunikasi tentang ketentuan ilmiah yang disepakati dan ditetapkan dalam penulisan tugas akhir yang berlaku di lingkungan Universitas dr. Soebandi sehingga menghasilkan tata tulis yang seragam,
- 2) Pedoman umum bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir dalam bentuk karya tulis ilmiah yang sistematis dan metodologis sesuai dengan etika penelitian dan kaidah bidang ilmu masing-masing,
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan sikap ilmiah dan tradisi akademik di kalangan mahasiswa pada khususnya dan seluruh sivitas akademik pada umumnya,
- 4) Sarana dalam menyebarluaskan pengetahuan dari Universitas dr. Soebandi kepada kalangan yang membutuhkan maupun masyarakat luas.

1.3 Jenis-Jenis Tugas Akhir

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa mahasiswa pada program sarjana atau sarjana terapan dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk skripsi atau karya prestasi mahasiswa.

a. Skripsi/Karya Tulis Ilmiah

Karya tulis ilmiah adalah karya yang disusun dalam bentuk laporan tertulis dari hasil penelitian, kajian, atau pemikiran untuk menjawab permasalahan tertentu sesuai dengan landasan teori dan metode ilmiah. Karya tulis yang dapat digolongkan sebagai karya tulis ilmiah secara umum terbagi dalam dua bagian, yaitu karya tulis berupa hasil penelitian dan karya tulis yang bukan berasal dari hasil penelitian atau bersifat hasil pemikiran. Karya tulis yang berupa hasil penelitian

yaitu seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel, makalah, dan laporan hasil penelitian lainnya. Sedangkan karya tulis yang bukan berasal dari hasil penelitian yaitu seperti artikel teoritik, makalah teoritik, buku ajar, dan lain-lain (Hermawan, 2019).

Beberapa jenis karya tulis ilmiah yang umumnya diterapkan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia adalah diantaranya adalah makalah, *paper* atau lembar kerja, laporan penelitian lapangan atau laporan praktik, skripsi, tesis, disertasi, buku, dan karya ilmiah populer. Karya tulis ilmiah yang ditetapkan untuk dilaksanakan di lingkungan Universitas dr. Soebandi saat ini adalah skripsi. Penyusunan skripsi diwajibkan bagi mahasiswa pada Program Sarjana sebagai salah satu syarat penyelesaian studi.

b. Karya Prestasi

Pertama : Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa dalam kegiatan kreativitas dan penalaran meliputi :

1. Ekuivalensi proposal kreativitas dan penalaran dan laporan akhir yang didanai oleh Pusat Prestasi Nasional/Direktorat Belmawa Kemendikbud sebagai ketua/anggota tim atau penulis utama/anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai A ; dan
2. Ekuivalensi prestasi mahasiswa dengan perolehan pendanaan pada program kreativitas dan penalaran Pusat Prestasi Nasional/Direktorat Belmawa Kemendikbud sebagai Ketua Tim atau Penulis Utama sebagai bentuk pengganti Skripsi dan atau Tugas Akhir dengan nilai yang ditentukan melalui Ujian Tugas Akhir.

Kedua : Rekognisi Karya prestasi mahasiswa dalam Kegiatan Kewirausahaan meliputi :

1. Ekuivalensi proposal dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Kemendikbud sebagai ketua/anggota tim atau penulis utama/anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai A;
2. Ekuivalensi prestasi mahasiswa dengan perolehan medali program kewirausahaan dari Kemendikbud sebagai ketua tim atau penulis utama sebagai bentuk pengganti skripsi atau tugas akhir dengan nilai ditentukan melalui ujian tugas akhir; dan

3. Ekuivalensi kegiatan kewirausahaan tingkat Universitas, Nasional atau sejenis diluar pendanaan Direktorat Belmawa yang pelaksanaannya minimal 4 bulan dengan mata kuliah yang relevan mendapat nilai A.
4. Ekuivalensi kegiatan kewirausahaan secara mandiri dengan pendanaan diluar pendanaan Direktorat Belmawa yang pelaksanaannya minimal 1 tahun dengan minimal mempunyai 2 karyawan dan pelaporan keuangan yang terstruktur sebagai bentuk pengganti skripsi atau tugas akhir dengan nilai ditentukan melalui ujian tugas akhir.

Ketiga : Rekognisi Karya Prestasi mahasiswa dalam kegiatan Karya Inovatif meliputi :

1. Ekuivalensi kegiatan yang mewujudkan karya inovatif dari perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud sebagai ketua/anggota atau penulis utama/anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan dengan nilai A; dan
2. Ekuivalensi prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam perlombaan tingkat nasional/internasional Kemendikbud sebagai ketua tim atau penulis utama sebagai bentuk pengganti skripsi dan atau Tugas Akhir dengan nilai yang ditentukan melalui Ujian Tugas Akhir.

Keempat : Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa dalam Kegiatan Perlombaan yaitu:

1. Ekuivalensi prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud di tingkat nasional/internasional sebagai ketua/anggota atau penulis utama/anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai A; dan
2. Ekuivalensi pemusatan Latihan nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal 6 (enam) bulan dengan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan/atau mata kuliah lain yang relevan mendapat nilai A.

Kelima : Rekognisi karya Prestasi Mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah meliputi :

1. Ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh Jurnal Internasional terindeks Scopus dan/atau Web of Science sebagai bentuk pengganti skripsi dengan nilai A;

2. Ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 sebagai pengganti skripsi atau tugas akhir dengan nilai yang ditentukan melalui ujian skripsi
3. Ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks scopus dan/atau Web of Science dengan mata kuliah yang relevan mendapat nilai A; dan
4. Ekuivalensi karya berupa artikel/makalah ilmiah yang disajikan dalam seminar nasional dan internasional dengan mata kuliah yang relevan dengan mendapat nilai A.

Keenam : Ekuivalensi karya cipta berupa paten (granted) dan paten sederhana (grandted) sebagai bentuk pengganti skripsi atau tugas akhir dengan nilai yang ditentukan melalui ujian skripsi.

1.4 Etika Penulisan

Pertanggungjawaban akademik dari sivitas akademika dalam proses pendidikan salah satunya adalah mempertanggungjawabkan kegiatan pendidikan secara akademik pula, termasuk dalam pelaksanaan tugas akhir dalam bentuk penyusunan karya tulis ilmiah (Wibowo, 2016). Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah penyusunan karya tulis ilmiah yang mengikuti kaidah ilmiah tanpa melanggar etika penulisan. Etika penulisan adalah seperangkat norma yang berlaku dalam penulisan karya tulis ilmiah. Norma-norma yang harus diperhatikan dan ditaati antara lain menyangkut pengutipan dan rujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, penyebutan sumber data atau informasi, serta kaidah lainnya yang masih saling terkait seperti bentuk dan format, sistematika, ukuran kertas dan huruf, Bahasa Indonesia baku, serta ejaan yang disempurnakan (Mansyur, 2018; Hermawan, 2019, Rif'ah dkk, 2019).

1.4.1 Etika Pengambilan Data

Beberapa aspek yang mungkin menjadi faktor permasalahan etika terkait pengambilan data (khususnya pengambilan data primer dalam *original research*), diantaranya yaitu berhubungan dengan subjek uji yang rentan (*vulnerable*), hewan uji, embrio hewan, dan benturan kepentingan (*conflict of interest*) (Pauwels, 2007).

Benturan kepentingan dapat terjadi ketika peneliti terlalu menonjolkan keunggulan penelitiannya tanpa menyampaikan risiko kepada responden ketika berupaya memperoleh izin termaklum dari calon partisipan. Dalam upaya meminimalisir permasalahan etika, maka sebelum melaksanakan penelitian yang melibatkan partisipan (terutama dengan kondisi rentan), hewan uji, dan embrio hewan sebagai subjek penelitian, peneliti harus memperoleh *ethical clearance* dari Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan di Universitas dr. Soebandi.

Partisipan selaku subjek penelitian dengan tingkat kerentanan yang tinggi seperti pasien cacat mental atau pasien dengan risiko jatuh yang tinggi, harus diberi informasi sejelas-jelasnya mengenai tujuan dan prosedur penelitian yang akan dilaksanakan beserta dampaknya (risiko dan ketidaknyamanan yang akan dialami). Tindakan ini bertujuan agar partisipan memaklumi sehingga peneliti memperoleh izin termaklum (*informed consent*), baik dari partisipan itu sendiri maupun dari orang yang diangkat menjadi walinya. Identitas narasumber atau informan perlu dipertimbangkan untuk tidak disebutkan jika pencantumannya dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Izin termaklum juga perlu diperoleh untuk penelitian yang menggunakan materi genetika manusia atau sampel hayati. Hal ini digunakan untuk menjamin validitas data yang akan diperoleh dan menjamin tidak ada penolakan atas hasil penelitian di kemudian hari.

Penelitian yang melibatkan hewan uji atau embrio hewan, harus mencantumkan prosedur perlakuan, jumlah yang digunakan, jumlah yang dikorbankan, cara pemusnahan, dengan tetap memperhatikan prinsip 3R dalam protokol penelitian, yaitu *replacement*, *reduction*, dan *refinement*. Peneliti harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh penggunaan hewan coba dalam penelitian (Stevani, 2016).

Adapun proses uji etik yang dilakukan calon peneliti harus memenuhi usulan protokol etik yang akan di masukkan ke Komite Etik Penelitian Kesehatan Universitas dr. Soebandi. Usulan protokol yang masuk meliputi manual 48 isian protokol, pengisian ceklist etik penelitian dengan penerapan 3 Prinsip, 7 Standar, dan 25 Pedoman: Kriteria/Dasar Pengambilan Keputusan Persetujuan Usulan Protokol: Laik Etik (KEPPKN-2018), Informed Consent Mendapatkan Persetujuan Setelah Penjelasan: Informasi esensial untuk calon peserta penelitian (WHO-CIOMS 2016) terdapat pada lampiran 49, serta formulir Infomed Concent 35 butir yaitu **Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*) seperti pada lampiran 49.**

Aspek lain yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam proses pengambilan data yaitu:

- 1) Penulis wajib bersikap sopan dalam proses pengambilan sumber data primer dari narasumber atau informan,
- 2) Tindak kecurangan seperti melakukan intervensi kepada responden dalam pengisian kuesioner atau kecurangan lainnya dalam bentuk apapun selama proses pengambilan data tidak diperkenankan,
- 3) Tindak *fabrication* (melaporkan data dan hasil yang tidak sebenarnya) dan *falsification* (memanipulasi bahan, peralatan, atau prosedur penelitian, maupun mengubah atau menghapus data atau hasil sehingga penelitian tidak terwakili secara akurat) tidak diperkenankan,
- 4) Penulis wajib mencantumkan semua sumber data (terutama data sekunder) yang digunakan dalam penelitian.

1.4.2 Pencegahan Plagiasi

Pencegahan plagiasi adalah upaya yang bersifat preventif terhadap tindakan plagiasi. Pada pelaksanaan penyusunan karya tulis ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain atau pihak lain sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Pemakaian bahan atau pikiran dari sumber atau pihak lain tanpa disertai sumber rujukan termasuk kecurangan atau pencurian karena mengakui tulisan, temuan, atau hasil pemikiran pihak lain sebagai karya intelektual sendiri.

Penulis harus meminta izin, jika menggunakan bahan dari seseorang atau suatu sumber milik orang lain (sebaiknya secara tertulis). Jika pemilik tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya dan menjelaskan bahan yang digunakan akan diambil secara utuh, sebagian, dimodifikasi, atau bersifat pengembangan. Universitas dr. Soebandi mewajibkan mahasiswa untuk melakukan pemeriksaan plagiasi di LPPM Universitas dr. Soebandi pada seluruh bagian inti dari tugas akhir yaitu meliputi BAB 1 hingga BAB 7 untuk penelitian *original research*. Batas nilai plagiasi yang ditetapkan untuk mahasiswa adalah tidak lebih dari 25%.

Mahasiswa yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran akan dikenakan sanksi, berupa sanksi administrasi hingga sanksi pembatalan gelar. Apabila karya tulis ilmiah dinyatakan tidak asli atau mahasiswa melakukan duplikasi maupun plagiat, maka ujian dibatalkan dan mahasiswa diharuskan menyusun Karya Tulis Ilmiah baru. Bagi mahasiswa yang telah lulus dan terbukti melakukan duplikasi atau plagiat, maka gelar akademik dan ijazah yang diperoleh dibatalkan.

1.5 Sistematika Isi Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa

Buku Pedoman ini mencakup ketentuan umum tentang penyusunan tugas akhir, prosedur penyusunan tugas akhir, sistematika penulisan dan penjabaran bagian tugas akhir, format penulisan tugas akhir dan pelaksanaan ujian tugas akhir. Buku pedoman ini juga disusun dengan harapan dapat menyeragamkan tata pemahaman mengenai jenis, sistematika, isi, dan tata cara penulisan karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir mahasiswa di lingkungan Universitas dr. Soebandi. Pedoman ini bersifat rujukan yang diikuti oleh seluruh sivitas akademika, namun memungkinkan untuk disesuaikan kembali dengan kondisi khusus pada setiap program studi.

BAB 2 KETENTUAN UMUM PENULISAN TUGAS AKHIR

2.1 Kedudukan Tugas Akhir dan Bobot Satuan Kredit Semester (SKS)

2.1.1 Kedudukan Tugas Akhir

Tugas akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, namun berbeda bentuk pada proses pembelajaran dan cara penilaiannya.

2.1.2 Bobot SKS

Penetapan bobot tugas akhir disesuaikan dengan bentuknya berdasarkan kurikulum yang berlaku di masing-masing program studi. Bobot tugas akhir ditetapkan 4-6 SKS yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 16-20 jam (bagi yang 4 SKS) atau 24-30 jam (bagi yang 6 SKS) selama satu semester.

2.2 Syarat Penyusunan Tugas Akhir

2.2.1 Persyaratan Akademik

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk melakukan penyusunan skripsi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Status mahasiswa aktif, yaitu telah terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan;
- 2) Jumlah SKS minimal 105 SKS untuk Program Sarjana;
- 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
- 4) Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian.

Syarat tersebut di atas diperlukan bukti Kartu Hasil Studi (KHS) yang discan dan diunggah ke Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM) pada menu skripsi.

2.2.2 Persyaratan Administratif

Mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Skripsi harus memenuhi persyaratan administratif seperti di bawah ini:

- 1) Telah memenuhi persyaratan akademik;
- 2) Memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai semester yang berlaku dengan mencantumkan Mata Kuliah Proposal/Skripsi yang telah ditandatangani oleh dosen wali;
- 3) Telah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan yang ditunjukkan dengan bukti pembayaran lunas SPP semester 1-6 bagi Program Sarjana;

- 4) Telah lunas pembiayaan tugas akhir.

2.3 Dosen Pembimbing dan Penguji

2.3.1 Personalia Pembimbing

- 1) Dalam penulisan skripsi atau tugas akhir, mahasiswa dibimbing oleh satu dosen pembimbing utama
- 2) Dosen pembimbing dapat digantikan dosen lain dengan persetujuan komisi bimbingan berdasarkan alasan yang dapat diterima setelah melalui konfirmasi dengan dosen yang bersangkutan. Pergantian pembimbing tersebut harus melalui tahapan usul mahasiswa yang diketahui komisi bimbingan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan pembimbing baru yang ditandatangani dekan.

2.3.2 Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji

- 1) Persyaratan Dosen Pembimbing Utama
 - (1) Merupakan dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli dan berpendidikan minimal S2 dengan bidang ilmu yang sesuai;
 - (2) Pembimbing utama harus memiliki bidang keilmuan dan/atau keahlian yang linier dengan topik penelitian mahasiswa. Bidang keilmuan dapat dilihat dari ijazah terakhir dosen yang bersangkutan sedangkan bidang keahlian tercermin dari penelitian yang ditekuni selama ini;
 - (3) Apabila belum ada dosen tetap yang memenuhi persyaratan sebagai dosen pembimbing utama sebagaimana yang tercantum pada nomor (1), maka sementara waktu rektor menetapkan kebijakan pengecualian yaitu dengan meminjam dosen dari institusi lain sambil tetap meningkatkan kompetensi dosen tetap yang ada;
 - (4) Dalam upaya penjaminan mutu, ditetapkan bahwa dalam satu tahun akademik minimal 60% dari keseluruhan pembimbing utama adalah setara dengan lektor kepala atau S3;

- (5) Pada kebutuhan tertentu seperti program kerja sama dengan universitas atau lembaga mitra dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), maka pembimbing skripsi program akademik dengan komposisi pembimbing pertama adalah dosen Universitas dr. Soebandi dan pembimbing kedua adalah dosen dari universitas atau lembaga mitra.

2) Persyaratan Dosen Penguji

Persyaratan yang ditetapkan bagi dosen penguji adalah sebagai berikut:

- (1) Ketua penguji merupakan dosen yang memiliki jabatan akademik dosen lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan kualifikasi dosen pembimbing utama dan mempunyai keahlian yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa;
- (2) Anggota penguji merupakan dosen/praktisi yang mempunyai keahlian khusus dan sesuai dengan bidang ilmu (latar belakang pendidikan/pengalaman/pelatihan).

2.3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing

1) Tugas dan tanggung jawab pembimbing utama meliputi:

- (1) Membimbing mahasiswa mulai menyusun rancangan (proposal) tugas akhir hingga penyusunan laporan hasil tugas akhir;
- (2) Menyediakan waktu dan memberikan bimbingan selama proses penulisan tugas akhir;
- (3) Mengarahkan dan membantu mahasiswa bimbingannya memperdalam telaah kepustakaan, pemanfaatan data dan menekankan pada metodologi;
- (4) Memberikan pengarahan dalam melakukan penelitian di lapangan dan/atau perpustakaan serta pemanfaatan data;
- (5) Memberi arahan dan masukan kepada mahasiswa bimbingannya dalam materi tugas akhirnya;
- (6) Memutuskan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti ujian tugas akhir.
- (7) Membimbing sistematika penulisan tugas akhir;
- (8) Membimbing pengorganisasian tugas akhir;
- (9) Menjadi fasilitator antara mahasiswa dan penguji pada saat ujian skripsi dan tugas akhir.

2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pembimbingan

- 1) Tiap pembimbing dibolehkan membimbing minimal 8 (delapan) pada proposal dan minimal 8 (delapan) pada hasil mahasiswa per semester atau disesuaikan dengan kondisi prodi dengan memperhatikan pemerataan dan jabatan akademik;
- 2) Pembimbingan dimulai dari pembuatan proposal penelitian sampai dengan pengesahan skripsi/tugas akhir;
- 3) Tiap kali kegiatan konsultasi (diskusi), pembimbing membubuhkan paraf pada lembar monitoring skripsi, serta mencantumkan saran perbaikan yang diperlukan;
- 4) Proses pembimbingan dilakukan melalui edufecta (SOP) terlampir

2.5 Desain Tugas Akhir

Dalam rangka memperlancar pengerjaan tugas akhir mahasiswa, dosen pembimbing dapat membantu mengarahkan mahasiswanya untuk memilih model/desain yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih desain tugas akhir yaitu *possibility* untuk pelaksanaan penelitian sesuai dengan topik yang diambil, ketersediaan data di lapangan, ataupun pertimbangan khusus lainnya (mahasiswa yang telah melampaui target waktu kelulusan). Model/desain tugas akhir dapat dipilih salah satu di antara desain berikut:

2.5.1 Studi dengan Data Primer

Data primer dapat dilaksanakan di lingkungan mahasiswa yang aman, atau data dapat diperoleh tanpa ada kontak langsung dengan subjek, dengan alternatif metode pengumpulan data seperti pengisian kuesioner via *google form* atau wawancara melalui telepon. Studi di laboratorium dapat dilaksanakan dengan pertimbangan khusus dan penerapan kewaspadaan yang tinggi, serta mendapatkan izin dari pihak terkait.

2.5.2 Studi dengan Data Sekunder

Penelitian dapat menggunakan data sekunder seperti data survei lokal/nasional yang *terpublish* secara umum ataupun data milik perorangan yang belum digunakan untuk membuat karya tulis ilmiah, dengan izin pemilik data. Penggunaan data sekunder seperti rekam medis diharapkan dapat dikaji ulang terkait dengan kemungkinan diberikanya perizinan penelitian daripihak penyedia pelayanan kesehatan.

BAB 3 PROSEDUR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

3.1 Penentuan Judul Tugas Akhir

Penentuan judul tugas akhir memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap mahasiswa menentukan area penelitian berdasarkan pembagian bidang keilmuan. Bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan bidang ilmu dibagi menjadi Keperawatan Dasar, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Kritis, Keperawatan Komunitas, Keperawatan Jiwa, Keperawatan Anak, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, Keperawatan Maternitas dan Keperawatan Holistik. Bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi bidang keilmuan dibagi menjadi Farmasi Klinis dan Komunitas, Kimia Farmasi, Teknologi Farmasi, dan Biologi Farmasi. Bagi mahasiswa Program Studi Teknologi Laboratorium Medik bidang keilmuan dibagi menjadi Hematologi, Kimia Klinik, Mikrobiologi (Bakteriologi, Mikologi, Parasitologi), Imunoserologi, Toksikologi Klinik, Biokimia, Biologi molekuler, dan Sitohistoteknologi. Bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan bidang ilmu dibagi menjadi asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan, asuhan kebidanan nifas, asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah, asuhan kebidanan kesehatan reproduksi, asuhan kebidanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, asuhan kebidanan KB, dan asuhan kebidanan komunitas;
- 2) Mahasiswa mengumpulkan rencana judul penelitian skripsi kepada komisi bimbingan;
- 3) Komisi bimbingan akan menentukan dosen pembimbing utama dan pembimbing anggota berdasarkan hasil rekap unggahan judul-judul dari mahasiswa;
- 4) Mahasiswa dapat menemui masing-masing pembimbing untuk melakukan konsultasi terkait tema atau judul penelitian yang akan diambil dengan menekankan pada keterbaruan masalah;

- 5) Judul penelitian yang telah disetujui antara pembimbing dan mahasiswa segera dilaporkan kepada komisi bimbingan untuk menghindari kesamaan judul dengan mahasiswa lainnya;
- 6) Bila judul penelitian dalam butir (5) tidak dapat diterima oleh komisi bimbingan karena alasan tertentu, maka mahasiswa yang bersangkutan menggunakan alternatif judul lain berdasarkan butir (2) untuk dipilih kembali oleh mahasiswa bersama-sama dengan dosen pembimbing.

3.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembimbingan

- 1) Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan secara *online* atau *offline*;
- 2) Waktu dan tempat kegiatan bimbingan sebaiknya dilaksanakan pada jam efektif kerja dan bertempat di area kampus Universitas dr. Soebandi;
- 3) Bila butir nomor (2) tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, pembimbing dan mahasiswa secara bersama-sama dapat menentukan waktu dan tempat kegiatan bimbingan;
- 4) Kegiatan bimbingan dapat dimulai dari menyusun rancangan penelitian/penetapan judul;
- 5) Setiap kali melakukan kegiatan bimbingan, mahasiswa wajib membawa lembar bimbingan skripsi dan tugas akhir (format terlampir). Mahasiswa mengisi lembar bimbingan sesuai ketentuan dan pembimbing membubuhkan paraf pada lembar bimbingan skripsi dan tugas akhir tersebut sebagai bukti telah dilaksanakannya kegiatan bimbingan;
- 6) Mahasiswa, pembimbing utama, dan pembimbing anggota wajib melakukan pertemuan secara bersama, minimal 1 kali tatap muka, dapat secara *online* atau *offline*, dibuktikan dengan menulis di lembar bimbingan skripsi dan tugas akhir (format terlampir).

3.3 Pengajuan Izin Penelitian

3.3.1 Izin Penelitian Berbasis Penelitian Komunitas

- 1) Mahasiswa meminta surat pengantar dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi;

- 2) Mahasiswa mengurus surat perizinan penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol);
- 3) Mahasiswa mengurus surat perizinan penelitian di tempat dilaksanakannya penelitian, misal di rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya.

3.3.2 Izin Penelitian Berbasis Penelitian Laboratorium

- 1) Mahasiswa mengurus surat perizinan penggunaan laboratorium (format terlampir), surat peminjaman alat dan/atau instrument yang akan digunakan di laboratorium yang terkait, serta surat penggunaan bahan untuk kepentingan penelitian;
- 2) Mahasiswa yang akan melakukan penelitian di laboratorium wajib membuat surat pernyataan izin orang tua atau wali dan mengunggah pada *link* yang akan diatur dan diinformasikan kemudian;
- 3) Mahasiswa bebas COVID-19 dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang berasal dari fasilitas kesehatan yang ada di area Jember dan menunjukkan hasil pemeriksaan COVID-19 **-negatif** dengan pemeriksaan minimal swab antigen;
- 4) Pada hari pertama melakukan penelitian di laboratorium, mahasiswa wajib mengunggah surat hasil pemeriksaan COVID-19 melalui *link* yang diinformasikan kemudian, untuk selanjutnya mendapatkan surat keterangan bebas COVID-19 dari Satuan Tugas COVID-19 Universitas dr. Soebandi.

3.4 Penggantian Dosen Pembimbing

Dalam proses penyelesaian skripsi terdapat kejadian khusus yang mengharuskan terjadinya penggantian/pengunduran diri dosen pembimbing. Pergantian pembimbing dimungkinkan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila sejak konsultasi pertama setelah penetapan pembimbing, kemudian pembimbing karena sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas membimbing, misal karena sakit atau studi lanjut, maka komisi bimbingan

dapat mengusulkan pembimbing pengganti dengan berkoordinasi dengan pihak Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi;

- 2) Proses bimbingan tidak berjalan secara efektif yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa dan bukti kronologis masalah;
- 3) Pembimbing tidak bersedia menjadi pembimbing berdasarkan surat rujukan atau kesediaan.

Prosedur penggantian pembimbing/penguji tugas akhir:

- 1) Mahasiswa berdiskusi dengan dosen pembimbing (dapat didampingi oleh pihak program studi) terkait dengan permohonan pergantian/pengunduran dosen pembimbing;
- 2) Apabila dosen yang mengundurkan diri harus menjelaskan alasan pengunduran diri tersebut, sedangkan apabila mahasiswa yang mengajukan permohonan penggantian dosen pembimbing mahasiswa harus menjelaskan alasan permohonan penggantian;
- 3) Mahasiswa membuat surat pernyataan untuk permohonan mengganti pembimbing, ditujukan kepada komisi bimbingan. Surat pernyataan diberi materai Rp 10.000, dan disertai dengan lampiran yang memuat kronologi dan alasan pemohon mengganti pembimbing (format surat pernyataan terlampir);
- 4) Komisi bimbingan bersama pihak program studi melakukan konfirmasi kepada dosen pembimbing yang bersangkutan sebelum memproses surat permohonan;
- 5) Apabila surat tersebut telah disetujui, maka program studi dapat memberikan surat pengantar pengajuan pergantian pembimbing untuk diproses pergantian dosen pembimbing skripsi;
- 6) Pemilihan dan konfirmasi kesediaan dosen pembimbing baru dilaksanakan oleh komisi bimbingan;
- 7) Pembuatan SK untuk dosen pembimbing baru.
- 8) Mahasiswa yang telah menerima pergantian dosen kemudian memproses dengan mengontak dosen pembimbing baru.

3.5 Pengajuan Ujian Seminar Proposal dan Seminar Hasil

3.5.1 Seminar Proposal

Pada bagian ini akan diuraikan tentang syarat dan tata tertib pada seminar proposal. Syarat untuk dapat mengikuti seminar proposal antara lain:

- 1) Seminar proposal dapat dilakukan apabila proposal yang dibuat telah memperoleh persetujuan dari pembimbing utama yang dibuktikan dengan lembar bimbingan proposal skripsi dan tanda tangan pembimbing pada lembar persetujuan seminar proposal;
- 2) Seminar proposal bersifat sidang terbuka dan wajib dihadiri minimal 10 mahasiswa dan didalamnya terdiri dari 1 orang *opponent*;
- 3) Seminar proposal diuji oleh ketua penguji, anggota penguji dan pembimbing utama, seluruh penguji akan menguji dalam waktu yang bersamaan dan berada dalam satu ruang (luring/daring);
- 4) Mahasiswa mengajukan permohonan seminar proposal yang diajukan kepada komisi bimbingan, dengan mengisi form blanko permohonan pelaksanaan seminar proposal (format terlampir), minimal 3 hari sebelum seminar proposal berlangsung dengan menunjukkan bukti ACC pembimbing;
- 5) Proposal diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum seminar;
- 6) Mahasiswa sekurang-kurangnya telah melakukan **bimbingan proposal sebanyak 8 (delapan) kali dengan dosen pembimbing**, dibuktikan dengan menyerahkan lembar bimbingan proposal skripsi; atau laporan tugas akhir (format terlampir) yang telah disetujui oleh kedua pembimbing;
- 7) Mahasiswa yang akan mengikuti seminar proposal sekurang-kurangnya telah pernah menghadiri 3 (tiga) kali seminar proposal mahasiswa lain dan pernah menjadi *opponent* minimal 1 kali yang dibuktikan dengan menyerahkan lembar mengikuti seminar proposal (format terlampir). Persyaratan ini tidak berlaku bagi 3 (tiga) peserta yang melaksanakan seminar proposal paling awal;
- 8) Teknis pelaksanaan seminar proposal yang dilakukan dengan cara *online* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (1) Menggunakan Aplikasi *Zoom*, *Google meet*, atau *WebEx*;
 - (2) **Tidak diperkenankan** menggunakan aplikasi *Video Call Whatsapp*;

- 9) Pelaksanaan seminar dipimpin oleh moderator (pembimbing). Bila moderator ingin menggunakan haknya sebagai penguji, maka ia menjadi penguji setelah anggota penguji lainnya mengajukan pertanyaan. Moderator bertugas untuk:
 - (1) Memimpin jalannya sidang;
 - (2) Mengatur waktu dalam uji sidang;
 - (3) Rekapitulasi nilai dari masing-masing penguji;
 - (4) Menyerahkan nilai pada komisi bimbingan;
- 10) Seminar proposal dilangsungkan selama ± 60 menit dengan alokasi waktu sebagai berikut:
 - (1) Pembukaan oleh moderator: 5 menit;
 - (2) Penyajian oleh mahasiswa: 10 menit;
 - (3) Tanya jawab: 45 menit;
- 11) Ketentuan *slide* presentasi seminar proposal penelitian, diantaranya:
 - (1) Jumlah *slide* presentasi dapat dibuat sebanyak 5 hingga 10 *slide*;
 - (2) *Slide* dibuat dalam bentuk *power point*, dapat meliputi tulisan, gambar, grafik, tabel dan lain-lain; Materi yang disampaikan diantaranya memuat latar belakang proposal penelitian dan alasan proposal tersebut perlu diteliti. Materi juga mencakup permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan, literatur maupun referensi dari penelitian terdahulu, teori yang digunakan, serta metodologi penelitian yang digunakan;
- 12) Hasil masukan pada waktu seminar dicatat dan digunakan untuk menyempurnakan proposal. **Perbaikan proposal penelitian diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 1 minggu setelah ujian.** Setelah proposal dinyatakan layak, mahasiswa dapat melanjutkan kegiatan penelitian termasuk penyusunan laporan skripsi dan tugas akhir.

3.5.2 Seminar Hasil

Seminar hasil (Sidang akhir tugas akhir) bersifat komprehensif dan tertutup bagi umum, sidang ini hanya diikuti oleh pembimbing utama, pembimbing anggota, penguji, serta mahasiswa yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya. Syarat untuk dapat mengikuti seminar hasil penelitian sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Tercatat aktif sebagai mahasiswa Universitas dr. Soebandi;
- 2) Telah menyelesaikan segala proses administrasi baik akademik dan keuangan;
- 3) IPK minimal 3,00;
- 4) Nilai minimal C pada semua mata kuliah;
- 5) Seminar hasil penelitian dapat dilakukan apabila skripsi yang disusun telah memperoleh persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing anggota, yang dibuktikan dengan tandatangan pada lembar persetujuan seminar hasil penelitian (format terlampir);
- 6) Permohonan seminar hasil penelitian diajukan kepada koordinator kelas pada masing-masing program studi dengan mengisi form permohonan pelaksanaan seminar hasil penelitian (format terlampir), minimal 3 hari sebelum seminar hasil penelitian berlangsung dengan menunjukkan bukti ACC dan pendukung lainnya;
- 7) Berkas hasil penelitian yang telah dijilid *softcover* warna biru tua (Program Studi S1 Keperawatan), warna merah muda (Program Studi Sarjana Kebidanan), dan biru langit (Program Studi Sarjana Farmasi) warna krem (Program Studi Teknologi Laboratorium Medik) digandakan sebanyak 4 eksemplar (2 untuk pembimbing, 1 penguji dan 1 untuk arsip mahasiswa). Cetakan gambar pada isi harus berwarna dan diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum ujian seminar hasil penelitian;
- 8) Mahasiswa yang telah melakukan **bimbingan penelitian minimal sebanyak 8 (delapan) kali**, dibuktikan dengan menyerahkan lembar bimbingan hasil skripsi dan laporan tugas akhir (format terlampir);
- 9) Seminar hasil penelitian dihadiri oleh dosen pembimbing utama (moderator), penguji dan penguji anggota;
- 10) Pelaksanaan seminar hasil penelitian dipimpin oleh moderator (pembimbing utama). Bila moderator ingin menggunakan haknya sebagai penguji, maka ia menjadi penguji setelah anggota penguji lainnya mengajukan pertanyaan. Moderator yang bertugas untuk:
 - (1) Memimpin jalannya sidang;
 - (2) Mengatur waktu dalam uji sidang;
 - (3) Rekapitulasi nilai dari masing-masing penguji;
 - (4) Menyerahkan nilai pada Komisi Bimbingan;

3.6 Penjadwalan Penyusunan Skripsi Beserta Ujian

[illegible]

3.7 Yudisium

Yudisium dilakukan oleh program studi apabila hasil nilai skripsi dinyatakan lulus (minimal B) dan telah direvisi dengan bukti persetujuan revisi dari masing-masing dosen pembimbing dan penguji. Pendaftaran yudisium dilakukan melalui program studi masing-masing. Mahasiswa diminta untuk mengisi form persyaratan mengikuti yudisium dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Form persyaratan dan dokumen yang dipersyaratkan dikumpulkan di bagian akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi.

BAB 4

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL

4.1 Sistematika Penulisan Proposal Skripsi

4.1.1 Sistematika Penulisan Proposal Skripsi (*Original Research* Menggunakan Hewan Coba/Tanpa Subjek Manusia)

1) Bagian Awal

(1) Halaman Sampul

Pada sampul memuat judul skripsi, jenis Karya Tulis Ilmiah, logo universitas, identitas penulis berupa nama dan NIM mahasiswa, identitas program studi, fakultas, universitas, kota dan tahun penulisan.

(2) Halaman Judul

Halaman judul berisikan komponen dan susunan yang sama dengan halaman sampul disertai dengan kalimat prasyarat gelar sesuai program studi masing-masing.

(3) Halaman Persetujuan

(Lihat lampiran pada bagian halaman persetujuan)

(4) Halaman Pengesahan

(Lihat lampiran pada bagian halaman pengesahan)

(5) Lembar Pernyataan Orisinalitas

Halaman pernyataan orisinalitas memuat pernyataan orisinalitas skripsi dengan isi dan format seperti pada lampiran dan dilengkapi tanda tangan serta materi Rp 10.000.

(6) Kata Pengantar

Kata pengantar memuat rasa syukur, uraian singkat proses penulisan, menggunakan Bahasa Indonesia baku, pengantaran kepada pembaca untuk memahami isi, harapan dan kritik penyempurnaan serta manfaat bagi berbagai pihak dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama proses penyelesaian.

(7) Daftar Isi

Halaman daftar isi memuat keseluruhan judul komponen skripsi mulai dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir skripsi yang diikuti dengan penunjukan halaman.

(8) Daftar Tabel

Halaman daftar tabel memuat urutan judul tabel yang diikuti dengan penunjukan halaman.

(9) Daftar Gambar

Halaman daftar gambar memuat urutan lampiran yang diikuti dengan penunjukan halaman.

(10) Daftar Lampiran

Halaman daftar lampiran memuat urutan lampiran yang diikuti dengan penunjukan halaman.

(11) Daftar Singkatan dan Simbol (jika ada)

Bagian ini berisi daftar simbol dan singkatan yang digunakan dalam naskah.

2) Bagian Inti

(1) BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang berisi landasan kontekstual yang melatarbelakangi penelitian dengan menggambarkan sistematika pemikiran yang mengarah pada pemilihan masalah penelitian (umum ke khusus), menunjukkan alasan penting dari penelitian dan dikaitkan dengan pengetahuan terkini, atau justifikasi yang terkait dengan masalah dalam penelitian, dilengkapi dengan penjabaran bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Bagian ini menjelaskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian. Rumusan masalah dirumuskan berdasarkan gejala masalah yang muncul. Gejala tersebut kemudian didukung dengan teori dan logika berpikir yang tepat, sehingga rumusan masalah dapat tersampaikan secara akurat. Terdapat tiga kriteria untuk menilai kualitas dari rumusan masalah: relevan, dapat dijalankan dalam realitasnya, dan menarik. Rumusan masalah dapat dikatakan relevan jika dapat berguna dari sudut pandang praktis, teoritis, atau keduanya.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum berisi tentang pernyataan tujuan, keinginan atau harapan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus berisi tentang pernyataan-pernyataan secara terperinci tentang tujuan, keinginan atau harapan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagian ini menjelaskan apa manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pembangunan dalam arti yang lebih luas.

1.5 Keaslian Penelitian

Memuat uraian sistematis tentang temuan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini sebaiknya dibuat dalam bentuk tabel yang berisi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

(2) BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Mengemukakan teori-teori atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi), yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian. Dalam hubungan ini, pemilihan bahan pustaka didasarkan pada dua kriteria, yaitu prinsip kemuktahiran dan prinsip relevansi dengan topik yang diteliti. Untuk penelitian yang menguji hipotesis, maka peneliti dapat membuat kesimpulan teori dan atau model teoritis sehingga tinjauan empiris dapat dicantumkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Bilamana memungkinkan, dinyatakan pula dalam model hipotesis dan atau langsung dalam suatu perumusan hipotesis. Sedangkan penelitian yang kualitatif, peneliti dapat membuat kerangka pemikiran dari konsep-konsep dalam tinjauan pustaka.

(3) BAB 3 KERANGKA KONSEP

Bagian ini terdiri dari kerangka konsep dan hipotesis penelitian.

3.1 Kerangka Konsep

Bagian ini merupakan suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang dilakukan.

3.2 Hipotesis Penelitian (jika ada)

Hipotesis adalah pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori tentang jawaban sementara terhadap suatu masalah. Hipotesis dikembangkan berdasarkan: teori-teori yang relevan, logika kausal yang didasarkan pada teori yang ada, dan penelitian sebelumnya. Pembuatan hipotesis yang ilmiah hendaknya dilakukan dengan cermat, teliti, terarah secara logis, dan dapat diuji.

(4) BAB 4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi uraian tentang desain penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, bahan atau materi penelitian, alat penelitian, variabel, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data yang dikumpulkan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai metode yang digunakan dalam proses mengumpulkan dan menganalisis data.

4.1 Desain Penelitian

4.2 Populasi dan Sampel

4.3 Variabel Penelitian

4.4 Tempat Penelitian

4.5 Waktu Penelitian

4.6 Definisi Operasional

4.7 Teknik Pengumpulan Data

4.8 Teknik Analisa Data

2) Bagian Akhir

Bagian akhir proposal merupakan bagian akhir yang tidak ditandai oleh judul BAB, namun penomoran halamannya melanjutkan nomor halaman sebelumnya. Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

(1) Daftar Pustaka

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam proposal penelitian dan disusun ke bawah menurut abjad berdasarkan nama belakang penulis atau pengarang. Kepustakaan yang digunakan dapat bersumber dari textbook Bahasa Indonesia maupun textbook Bahasa Inggris, jurnal, majalah, buletin, atau hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi) terbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir.

(2) Lampiran

Bagian ini diawali halaman kosong yang ditandai dengan kata lampiran yang diletakkan di tengah bidang pengetikan. Halaman ini tidak diberi nomor, tetapi ikut dihitung.

Lampiran merupakan bagian yang menyajikan berbagai bahan yang digunakan dalam penyusunan proposal. Lampiran memberikan beberapa penjelasan-penjelasan yang lebih detail yang dianggap perlu di dalam penulisan proposal tugas akhir, tetapi dirasa mengganggu jika diletakkan di dalam proposal. Lampiran harus diberi nomor dan judul lampiran sesuai dengan pengelompokan ataupun kumpulan berkas yang disertakan.

4.1.2 Sistematika Penulisan Proposal Skripsi (*Original Research Menggunakan Subjek Manusia*)

1) Bagian Awal

(1) Halaman Sampul

Pada sampul memuat judul skripsi, jenis Karya Tulis Ilmiah, logo universitas, identitas penulis berupa nama dan NIM mahasiswa, identitas program studi, fakultas, universitas, kota dan tahun penulisan.

(2) Halaman Judul

Halaman judul berisikan komponen dan susunan yang sama dengan halaman sampul disertai dengan kalimat prasyarat gelar sesuai

program studi masing-masing.

- (3) Halaman Persetujuan
(Lihat lampiran pada bagian halaman persetujuan)
- (4) Halaman Pengesahan
(Lihat lampiran pada bagian halaman pengesahan)
- (5) Lembar Pernyataan Orisinalitas
Halaman pernyataan orisinalitas memuat pernyataan orisinalitas skripsi dengan isi dan format seperti pada lampiran dan dilengkapi tanda tangan serta materi Rp 10.000
- (6) Kata Pengantar
Kata pengantar memuat rasa syukur, uraian singkat proses penulisan, menggunakan Bahasa Indonesia baku, pengantar kepada pembaca untuk memahami isi, harapan dan kritik penyempurnaan serta manfaat bagi berbagai pihak dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama proses penyelesaian.
- (7) Daftar Isi
Halaman daftar isi memuat keseluruhan judul komponen skripsi mulai dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir skripsi yang diikuti dengan penunjukan halaman.
- (8) Daftar Tabel
Halaman daftar tabel memuat urutan judul tabel yang diikuti dengan penunjukan halaman.
- (9) Daftar Gambar
Halaman daftar gambar memuat urutan lampiran yang diikuti dengan penunjukan halaman.
- (10) Daftar Lampiran
Halaman daftar lampiran memuat urutan lampiran yang diikuti dengan penunjukan halaman.
- (11) Daftar Singkatan dan Simbol (jika ada)
Bagian ini berisi daftar simbol dan singkatan yang digunakan dalam naskah.

2) Bagian Inti

A. JUDUL PENELITIAN

1.1 Lokasi

Bagian ini memuat lokasi penelitian.

1.2 Persetujuan etik

Bagian ini memuat keterangan jenis penelitian multi-senter atau tidak. Selain itu, jika multi-senter perlu dideskripsikan apakah sudah mendapatkan persetujuan etik dari senter/institusi yang lain (lampirkan jika sudah).

B. IDENTIFIKASI

2.1 CV penelitian

Bagian ini memuat identitas/curriculum vitae (CV) peneliti utama, anggota peneliti, serta lembaga sponsor (nama lembaga dan alamat).

C. PROTOKOL PENELITIAN

3.1 Ringkasan

Ringkasan dalam 200 kata, (ditulis dalam bahasa yang mudah difahami oleh —awamll bukan dokter/profesional kesehatan). Ringkasan memuat latar belakang, tujuan penelitian, metode, dan luaran penelitian (minimal dokumen manuskrip yang terpublish di repository UDS).

3.2 Latar Belakang

Bagian ini memuat alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan (urgensi penelitian), justifikasi masalah, dan identifikasi masalah penelitian (dimulai dari lingkup yang luas misalnya negara, wilayah, ke lokal).

D. ISU ETIK PENELITIAN

Bagian ini memuat pendapat peneliti tentang isyu etik yang mungkin dihadapi dalam penelitian, dan bagaimana cara menanganinya.

E. KAJIAN PUSTAKA

5.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi konsep teori yang berkaitan dengan penelitian dan ringkasan hasil-hasil studi sebelumnya yang sesuai topik penelitian, baik yang sudah maupun yang sudah dipublikasikan, termasuk jika ada kajian-kajian pada hewan.

5.2 Kerangka Teori

Bagian ini memuat kerangka teori penelitian.

5.3 Kerangka Konsep

Bagian ini memuat kerangka konsep penelitian.

F. KONDISI LAPANGAN

6.1 Lokasi Penelitian

Bagian ini berisi gambaran singkat tentang lokasi penelitian.

6.2 Fasilitas

Bagian ini memuat informasi ketersediaan fasilitas yang tersedia di lapangan yang menunjang penelitian.

6.3 Demografis

Bagian ini menjelaskan informasi demografis/epidemiologis yang relevan tentang daerah penelitian.

G. DESAIN PENELITIAN

7.1 Tujuan Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus.

7.2 Hipotesis

Pada bagian ini menjelaskan tentang hipotesa penelitian.

7.3 Pertanyaan Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang pertanyaan penelitian (rumusan masalah).

7.4 Asumsi & Variabel Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang asumsi dan variabel penelitian.

7.5 Desain Penelitian

Bagian ini menjelaskan deskripsi detil tentang desain penelitian.

7.6 Metode

Bagian ini memuat deskripsi metode (bila uji coba klinis) tentang apakah kelompok treatment ditentukan secara random dan apakah blinded atau terbuka.

H. SAMPLING

8.1 Subjek Penelitian

Bagian ini berisi tentang penentuan sampel, perhitungan sampel, dan metode pengambilan sampel secara statistik.

8.2 Kriteria Partisipan

Bagian berisi tentang kriteria partisipan atau subyek dan justifikasi exclude/include-nya.

8.3 Sampling Kelompok Rentan

Bagian ini menjelaskan tentang alasan melibatkan anak atau orang dewasa yang tidak mampu memberikan persetujuan setelah penjelasan, atau kelompok rentan, serta langkah langkah bagaimana meminimalisir bila terjadi resiko (tuliskan “tidak relevan” bila penelitian tidak mengikutsertakan kelompok rentan).

I. INTERVENSI

9.1 Deskripsi Intervensi

Bagian ini mendeskripsikan dan menjelaskan semua intervensi (metode administrasi treatment, termasuk rute administrasi, dosis, interval dosis, dan masa treatment produk yang digunakan (tuliskan “Tidak relevan” bila bukan penelitian intervensi).

Selain itu, bagian ini juga berisi rencana dan justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar terapi/terapi baku selama penelitian. Treatment/Pengobatan lain yang mungkin diberikan atau diperbolehkan, atau menjadi kontraindikasi, selama penelitian juga harus dijelaskan. Bagian ini juga harus mendeskripsikan test klinis atau lab atau test lain yang harus dilakukan.

J. MONITORING PENELITIAN

10.1 Monitoring Penelitian

Bagian ini berisi pencatatan treatment pada subjek yang diberikan perlakuan. Selain itu, sampel dari form laporan kasus yang sudah distandarisir, metode pencatatan respon terapeutik (deskripsi dan evaluasi metode dan frekuensi pengukuran), prosedur follow- up, dan, bila mungkin, ukuran yang diusulkan untuk menentukan tingkat kepatuhan subyek yang menerima treatment perlu dicantumkan.

K. PENGHENTIAN PENELITIAN

11.1 Penghentian Penelitian

Bagian ini berisi tentang aturan atau kriteria kapan subyek bisa diberhentikan dari penelitian atau uji klinis, atau, dalam hal studi multi senter, kapan sebuah pusat/lembaga di non aktipkan, dan kapan penelitian bisa dihentikan.

11.2 Alasan

Bagian ini memuat tentang alasan penghentian penelitian.

L. ADVERSE EVENT & KOMPLIKASI

12.1 Metode Pencatatan dan Pelaporan

Bagian ini memuat metode pencatatan dan pelaporan adverse events atau reaksi, dan syarat penanganan komplikasi.

12.2 Resiko

Bagian ini berisi tentang resiko-resiko yang diketahui dari adverse events, termasuk resiko yang terkait dengan masing masing rencana intervensi, dan terkait dengan obat, vaksin, atau terhadap prosedur yang akan diuji cobakan.

M. PENANGANAN KOMPLIKASI

13.1 Penanganan

Bagian ini memuat rencana detil bila ada resiko lebih dari minimal/luka fisik, membuat rencana detil, adanya asuransi, adanya fasilitas pengobatan/biaya pengobatan, dan kompensasi jika terjadi disabilitas atau kematian.

N. MANFAAT

14.1 Manfaat Penelitian

Bagian ini memuat manfaat penelitian secara pribadi bagi subyek dan bagi yang lainnya.

14.2 Manfaat Aplikatif

Bagian ini berisi tentang manfaat penelitian bagi penduduk, termasuk pengetahuan baru yang kemungkinan dihasilkan oleh penelitian.

O. JAMINAN KEBERLANJUTAN

15.1 Keberlanjutan

Bagian ini berisi tentang deskripsi kemungkinan keberlanjutan akses bila hasil intervensi menghasilkan manfaat yang signifikan, modalitas yang tersedia, pihak-pihak yang akan mendapatkan keberlangsungan pengobatan, organisasi yang akan membayar, serta lama waktunya.

P. INFORMED CONSENT

16.1 Cara Memperoleh Informed Consent

Bagian ini memuat tentang cara untuk mendapatkan informed consent dan prosedur yang direncanakan untuk mengkomunikasikan informasi penelitian (Penjelasan Sebelum Persetujuan/PSP) kepada calon subyek, termasuk nama dan posisi wali bagi yang tidak bisa memberikannya.

16.2 Perencanaan Monitoring Kesehatan Ibu dan Anak

Pada bagian ini menjelaskan tentang adanya perencanaan untuk memonitor kesehatan ibu dan kesehatan anak jangka pendek maupun jangka panjang (diisi jika penelitian melibatkan ibu hamil).

Q. WALI

17.1 Wali/Orang Tua

Bagian ini menjelaskan tentang adanya wali yang berhak bila calon subyek tidak bisa memberikan informed consent, atau orang tua atau wali yang berhak bila anak paham tentang

informed consent tapi belum cukup umur.

R. BUJUKAN

18.1 Deskripsi Bujukan

Bagian ini memuat deskripsi bujukan atau insentif (bahan kontak) bagi calon subyek untuk ikut berpartisipasi, seperti uang, hadiah, layanan gratis, atau yang lainnya. Besaran insentif harus terbilang (nominal rupiah) dalam dekripsi bujukan.

18.2 Rencana dan Prosedur

Bagian ini menjelaskan tentang rencana dan prosedur, serta orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan bahaya atau keuntungan peserta, atau tentang riset lain tentang topik yang sama, yang bisa mempengaruhi keberlangsungan keterlibatan subyek dalam penelitian.

18.3 Perencanaan Menginformasikan Hasil Penelitian

Bagian ini berisi tentang perencanaan untuk menginformasikan hasil penelitian pada subyek atau partisipan.

S. PENJAGAAN KERAHASIAAN

19.1 Proses Rekrutmen Subjek

Bagian ini menjelaskan tentang proses rekrutmen subyek (misalnya lewat iklan), serta langkah langkah untuk menjaga privasi dan kerahasiaan selama rekrutmen.

19.2 Proteksi Kerahasiaan Data

Pada bagian ini mendeskripsikan langkah-langkah proteksi kerahasiaan data pribadi, dan penghormatan privasi orang, termasuk kehati-hatian untuk mencegah bocornya rahasia hasil test genetik pada keluarga kecuali atas izin dari yang bersangkutan.

19.3 Informasi Koding

Bagian ini menjelaskan tentang informasi koding; bila ada, untuk identitas subyek, di mana di simpan dan kapan, bagaimana dan oleh siapa bisa dibuka bila terjadi emergensi.

19.4 Penggunaan Data Personal/Material Biologis

Bagian ini harus mendeskripsikan kemungkinan penggunaan lebih jauh dari data personal atau material biologis/BBT.

T. RENCANA ANALISIS

20.1 Analisis Statistik

Bagian ini berisi tentang rencana analisa statistik, dan kreteria bila atau dalam kondisi bagaimana akan terjadi penghentian dini keseluruhan penelitian.

U. MONITOR KEAMANAN

21.1 Rencana Monitoring Keamanan Obat/Intervensi

Bagian ini memuat tentang rencana untuk memonitor keberlangsungan keamanan obat atau intervensi lain yang dilakukan dalam penelitian atau trial, dan, bila diperlukan, pembentukan komite independen untuk data dan safety monitoring.

V. KONFLIK KEPENTINGAN

22.1 Regulasi Konflik

Bagian ini berisi tentang pengaturan untuk mengatasi konflik finansial atau yang lainnya yang bisa mempengaruhi keputusan para peneliti atau personil lainnya; menginformasikan pada komite lembaga tentang adanya conflict of interest; komite mengkomunikasikannya ke komite etik dan kemudian mengkomunikasikan pada para peneliti tentang langkah langkah berikutnya yang harus dilakukan.

W. MANFAAT SOSIAL

23.1 Manfaat Sosial

Bagian ini menjelaskan tentang manfaat sosial untuk penelitian yang dilakukan pada seting sumberdaya lemah, kontribusi yang dilakukan sponsor untuk capacity building untuk review ilmiah dan etika dan untuk riset-riset kesehatan di negara tersebut; dan jaminan bahwa tujuan capacity building adalah agar sesuai nilai dan harapan para partisipan dan komunitas tempat penelitian.

23.2 Protokol Penelitian (Dokumen)

Protokol penelitian (dokumen) yang dikirim ke komite etik harus meliputi deskripsi rencana pelibatan komunitas, dan

menunjukkan sumber-sumber yang dialokasikan untuk aktivitas aktivitas pelibatan tersebut. Dokumen ini menjelaskan apa yang sudah dan yang akan dilakukan, kapan dan oleh siapa, untuk memastikan bahwa masyarakat dengan jelas terpetakan untuk memudahkan pelibatan mereka selama riset, untuk memastikan bahwa tujuan riset sesuai kebutuhan masyarakat dan diterima oleh mereka. Bila perlu masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan protokol atau dokumen ini.

X. HAK ATAS DATA

24.1 Hak Publikasi Hasil Riset

Bagian ini menguraikan tentang pernyataan pemilik hak publikasi hasil riset, dan kewajiban untuk menyiapkan bersama dan diberikan pada para PI draft laporan hasil riset.

Y. PUBLIKASI

25.1 Rencana Publikasi

Bagian ini menjelaskan tentang rencana publikasi hasil pada bidang tertentu (seperti epidemiology, generik, sosiologi). Selain itu, pada bagian ini juga harus memaparkan rencana publikasi bila hasil riset negatif.

Z. PENDANAAN

Bagian berisi tentang penjabaran sumber dan jumlah dana riset; lembaga funding/sponsor, dan deskripsi komitmen finansial sponsor pada kelembagaan penelitian, pada para peneliti, para subyek riset, dan, bila ada, pada komunitas.

AA. KOMITMEN ETIK

27.1 Pernyataan Peneliti

Bagian ini memuat pernyataan peneliti utama bahwa prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman ini akan dipatuhi (lampirkan scan Surat Pernyataan).

27.2 Riwayat Usulan Review Protokol Etik

Bagian ini berisi tentang riwayat usulan review protokol etik sebelumnya dan hasilnya (isi dengan judul dan tanggal

penelitian, dan hasil review Komite Etik) (lampirkan Daftar Riwayat Usulan Kaji Etiknya).

27.3 Pernyataan Tidak Ada Pemalsuan Data

Bagian ini berisi tentang pernyataan bahwa bila terdapat bukti adanya pemalsuan data akan ditangani sesuai peraturan /ketentuan yang berlaku.

BB. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam proposal penelitian dan disusun ke bawah menurut abjad berdasarkan nama belakang penulis atau pengarang. Kepustakaan yang digunakan dapat bersumber dari textbook Bahasa Indonesia maupun textbook Bahasa Inggris, jurnal, majalah, buletin, atau hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi) terbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Penulisan sitasi dan daftar pustaka harus menggunakan perangkat lunak referencing manager, misalnya EndNote, Mendeley, atau Zotero.

CC. LAMPIRAN

Bagian ini diawali halaman kosong yang ditandai dengan kata lampiran yang diletakkan di tengah bidang pengetikan. Halaman ini tidak diberi nomor, tetapi ikut dihitung. Lampiran merupakan bagian yang menyajikan berbagai bahan yang digunakan dalam penyusunan proposal. Lampiran memberikan beberapa penjelasan- penjelasan yang lebih detail yang dianggap perlu di dalam penulisan proposal tugas akhir, tetapi dirasa mengganggu jika diletakkan di dalam proposal. Lampiran harus diberi nomor dan judul lampiran sesuai dengan pengelompokan ataupun kumpulan berkas yang disertakan. Berikut merupakan lampiran yang wajib disertakan di proposal skripsi:

1. CV Peneliti Utama
2. CV Anggota Peneliti
3. Daftar Lembaga Sponsor
4. Surat-surat pernyataan
5. Formulir Laporan kasus/Kuesioner, dll
6. Informed Consent 35 butir

BAB 5 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Judul Artikel ditulis dengan Bahasa Indonesia maksimal 15 kata, hindari singkatan dan rumus yang tidak dikenal secara luas. Judul artikel ditulis dengan ketentuan: Center, Bold, Times New Roman font 14.

The title is written in English with a maximum of 15 words, Avoid using abbreviations and formulas that are not widely known. Center, Bold, Times New Roman font 14.

Nama Penulis^{1*}, Nama Penulis², Nama Penulis³

¹Program Studi, Fakultas (jika ada), Universitas, email.....

²Program Studi, Fakultas (jika ada), Universitas, email.....

³Program Studi, Fakultas (jika ada), Universitas, email.....

*Korespondensi Penulis : email@gmail.com

Received:

Accepted:

Published:

Abstrak

Latar Belakang: Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan jumlah kata 100-250 kata. Abstrak ditulis dalam 1 paragraf dengan urutan latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan. (Times New Roman; 10 pt; spasi 1). Abstrak dilengkapi dengan Keywords, terdiri dari 3-5 kata.

Tujuan:

Metode:

Hasil:

Kesimpulan:

Kata Kunci:;;;;

Abstract

Background: The Abstract is written in English and Indonesia with word limitation 100 to 250 words. It should be prepared in one paragraph covers introduction, objectives, method, result, and conclusions made in one paragraph. (Times New Roman; 10 pt; space 1). The abstract is equipped with keywords consisting of 3-5 words.

Purpose:

Methods:

Results:

Conclusions:

Keywords:;;;;

PENDAHULUAN

Penjelasan tentang latar belakang penelitian dan didukung oleh literatur yang relevan. Menjelaskan studi-studi sebelumnya mengapa penelitian/studi Anda perlu dilakukan. Menjelaskan pentingnya penelitian dilakukan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Latar belakang disusun menggunakan skema piramida terbalik dari informasi umum ke informasi yang spesifik. Salah satu penyebabnya adalah jumlah pendonor darah di PMI Sleman baru mencapai 1% dari jumlah penduduk di Sleman.(1)

Tujuan penelian harus dirumuskan dengan jelas dan merupakan turunan dari tema yang diangkat dalam artikel. (Times New Roman; 12 pt; spasi 1,5).

METODE

Penjelasan tentang waktu dan lokasi penelitian. Penjelasan jenis penelitian yang digunakan (kuantitatif, kualitatif, atau campuran) dan rancangan penelitian yang dipilih. Penjelasan populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel yang digunakan.

Penjelasan tentang instrumen, alat, atau kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Menjelaskan prosedur pengumpulan data. Menjelaskan metode analisis data dan alat yang digunakan untuk mengolah data. Jika metode penelitian mengacu pada prosedur standar, maka ditulis standarnya. (Times New Roman; 12 pt; spasi 1,5).

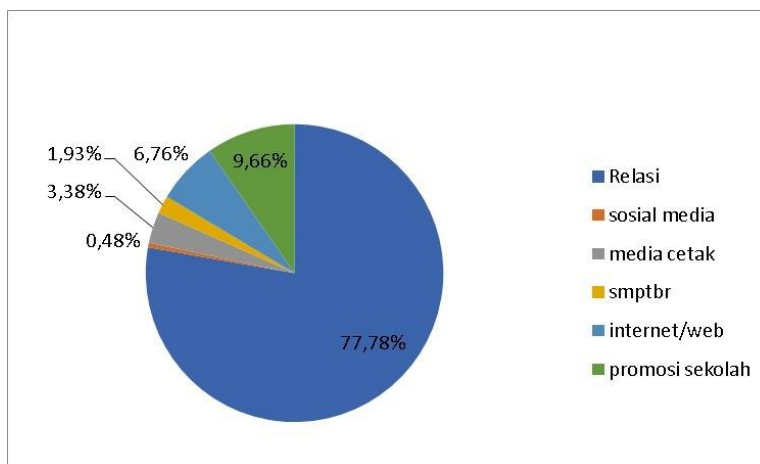
HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan karakteristik responden dan hasil analisis data. Hasil penelitian dapat berupa tabel atau gambar atau keduanya. Tabel terbuka dan sederhana, serta gambar yang difokuskan pada objek yang diteliti dengan ukuran yang proporsional (diupayakan dalam format JPG). Baik tabel maupun gambar diberi nomor urut dan sumbernya. Untuk kepentingan kualitas tampilan naskah, tabel diformatkan dalam Microsoft word atau excel dan gambar diformatkan dalam JPG resolusi minimal 300 dpi. Tabel dan gambar tidak boleh terputus, harus di satu halaman. (Times New Roman; 12 pt; spasi 1,5).

Tabel 1. Karakteristik responden(subjek penelitian) (Times New Roman; 11 pt; spasi 1).

Karakteristik	n	(%)
Umur (Tahun)		
17-25	1	100
26-35		
36-45		
46-55		
56-65		
Jenis Kelamin		
Laki-laki		
Perempuan		
Pendidikan		
dst		

Intepretasi hasil penelitian/studi, hubungannya dengan penelitian sebelumnya, dan implikasi hasil penelitian terhadap bidang kesehatan masyarakat. Jelaskan juga kekuatan dan keterbatasan penelitian/studi Anda.



Gambar 1. Xxxxxxx

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jelaskan saran untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya. (Times New Roman; 12 pt; spasi 1,5).

ACKNOWLEDGEMENTS

Jika ada yang menjelaskan tentang ucapan terima kasih kepada intitusi/instansi yang telah mendanai penelitian serta asisten peneliti yang terlibat dalam penelitian. (Times New Roman; 12 pt; spasi 1,5).

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustakan menggunakan reference manager (EndNote, Mendeley, Zotero, etc.) dengan style American Psychological Association (APA). Jumlah referensi minimal 12, sebanyak 80% adalah sumber jurnal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sumber buku dapat digunakan dalam kurun waktu minimal 10 tahun terakhir). Penulisan Referensi Buku, Tesis, Disertasi, dan Website menyesuaikan dengan reference manager (EndNote, Mendeley, Zotero, etc.) menggunakan style American Psychological Association (APA). (Times New Roman; 11 pt; spasi 1).

- Pebriarti, I. W. 2018. Hubungan Kadar Serum *Indoxyl Sulfate* dengan Lama Menjalani Hemodialisis pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik di RSD dr Soebandi. *Tesis*. Program Magister Farmasi Klinik Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sari, L. P. 2021. Hubungan Waktu Tunggu Pelayanan Resep dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. *Skripsi*. Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr Soebandi. Jember.
- Fujii, H., K. Nakai, and M. Fukagawa. 2011. Role of Oxidative Stress and Indoxyl Sulfate in Progression of Cardiovascular Disease in Chronic Kidney Disease. *Therapeutic Apheresis and Dialysis*. 15(2): 125–128.
- Ohtake, T. and S. Kobayashi. 2017. Impact of Vascular Calcification on Cardiovascular Mortality in Hemodialysis Patients: Clinical Significance. Mechanisms and Possible Strategies for Treatment. *Renal Replacement Therapy*. 3(13): 1–11.

BAB 6 FORMAT PENULISAN AKHIR

1. BAGIAN 1

Protokol (sesuai ketentuan pada BAB 4)

2. BAGIAN 2

Manuskrip (sesuai ketentuan pada BAB 5)

DAFTAR PUSTAKA

(menggunakan style American Psychological Association (APA); Times New Roman; 11 pt; spasi 1).

LAMPIRAN

(sesuai contoh pada halaman lampiran)

6.1 Bahan dan Ukuran Kertas

Bahan yang digunakan adalah kertas HVS berat 80 gram. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 (210 mm x 297 mm). Sampul skripsi menggunakan bahan *buffalo* yang diperkuat dengan karton jepang dan dilengkapi dengan laminasi plastik. Pembatas antara bab yang satu dengan bab yang lain menggunakan kertas *doorslag* dengan warna sesuai yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.

6.2 Penggunaan Bahasa

Proposal skripsi harus disusun dengan memperhatikan kaidah bahasa. Penulisan yang disusun sesuai kaidah bahasa bertujuan agar pembaca dapat memahami maksud yang disampaikan oleh penulis dengan baik. Penggunaan bahasa dalam penyusunan Skripsi mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bahasa yang digunakan merupakan bahasa baku sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
- 2) Kalimat yang disusun memiliki subjek, predikat, objek dan/atau keterangan;
- 3) Kalimat disusun secara efektif menggunakan pemilihan kata yang tepat;
- 4) Satu paragraf hanya memiliki 1 pokok pikiran atau gagasan;
- 5) Setiap paragraf minimal terdiri dari 2 kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas yang saling terkait dan berhubungan;
- 6) Istilah yang digunakan adalah istilah dalam Bahasa Indonesia atau kataserapan yang sudah baku sesuai KBBI;
- 7) Pemakaian bahasa asing ditulis dengan huruf miring/*italic* bila belum ada padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- 8) Penggunaan istilah yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia dapat disertai kata penjelas/konfirmasi istilah dan diletakkan dalam kurung bila dirasa sangat perlu dan hanya pada kali pertama penulisan;
- 9) Penggunaan tanda hubung dan tanda baca seperti koma, titik, titik koma, titik dua dan lain-lain tidak didahului oleh spasi, tetapi diberi spasi setelahnya;
- 10) Penggunaan tanda petik dan tanda kurung tidak dipisah/diberi spasi dengan bagian yang diapit;
- 11) Bilangan dalam kalimat yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata dapat ditulis dengan huruf, kecuali bila digunakan secara berurutan seperti dalam perincian;

- 12) Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang mengawali kalimat harus dieja dengan huruf;
- 13) Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik;
- 14) Beberapa hal yang harus dihindari:
 - (1) Penggunaan kata ganti yang tidak tepat;
 - (2) Penggunaan kata hubung dan kata depan di awal kalimat yang tidak tepat;
 - (3) Penggunaan kata-kata yang tidak tepat sebagai penghubung seperti: *di mana* atau *yang mana*;
 - (4) Penyusunan kalimat majemuk bertingkat yang tidak benar.

6.3 Pengetikan dan Penjilidan

Pengetikan dimulai dari batas tepi kiri hingga ke batas tepi kanan sehingga ruang yang terdapat dalam naskah terisi penuh, kecuali bila memasukkan rumus, persamaan, tabel, gambar. Kata pertama dalam sebuah kalimat diawali dengan huruf kapital. Pengetikan terkait batas tepi, jenis huruf, alenia baru, jarak baris diuraikan lebih lanjut.

6.3.1 Batas Tepi

Batas-batas pengetikan naskah ditinjau dari tepi kertas menggunakan *layout* sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1) Tepi atas (<i>top</i>) | : 4 cm |
| 2) Tepi bawah (<i>bottom</i>) | : 3 cm |
| 3) Tepi kanan (<i>right</i>) | : 3 cm |
| 4) Tepi kiri (<i>left</i>) | : 4 cm |

6.3.2 Jenis Huruf dan Ukuran

Naskah dicetak pada satu muka kertas (tidak diperbolehkan bolak-balik), kecuali untuk keperluan diskusi, diperbolehkan bolak-balik untuk menghemat kertas. Naskah diketik menggunakan komputer dengan program Microsoft Word.

Jenis huruf adalah Times New Roman dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Ukuran 14 dan tebal untuk judul skripsi maksimal 17 kata;
- 2) Ukuran 12 dan tebal untuk judul bab, judul sub bab, dan judul sub-subbab;
- 3) Ukuran 12 untuk isi naskah;

- 4) Ukuran 10 untuk catatan kaki dan keterangan sumber pada tabel maupun gambar;
- 5) Bagian lainnya yang tidak diuraikan diatur sebagaimana contoh pada lampiran.

6.3.3 Alinea Baru

Alinea baru ditulis menjorok sebanyak lima ketukan dari batas tepi kiribidang pengetikan atau menggunakan pengaturan otomatis *tab*. Alinea yang satu dengan alinea lain (dalam satu sub bab maupun dalam satu sub-sub bab) tidak dipisahkan oleh spasi kosong.

6.3.4 Jarak Baris

Jarak antara judul bab dan kalimat pertama dari naskah skripsi maupun jarak antara judul bab dengan sub bab (bila secara langsung diikuti oleh sub bab) adalah empat spasi. Masing-masing bab disusun pada halaman baru.

Jarak antara judul sub bab terhadap baris pertama kalimat uraiannya adalah dua spasi. Jarak antara judul sub-subbab dengan kalimat pertama uraiannya adalah dua spasi. Jarak antara kalimat terakhir uraian sub bab dengan sub bab berikutnya adalah empat spasi. Sedangkan jarak antara kalimat terakhir uraian sub-sub bab dengan sub-sub bab berikutnya menggunakan dua spasi.

Jarak baris pada bagian awal, isi dan bagian akhir skripsi menggunakan pengaturan sebagai berikut:

1) Bagian Awal

Bagian awal dari skripsi yaitu sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan (jika telah lulus seminar hasil skripsi), lembar pernyataan orisinalitas, lembar pembimbingan, lembar persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar singkatan dan simbol (bila ada) menggunakan aturan spasi sebagai berikut:

- (1) Lembar pernyataan orisinalitas menggunakan satu spasi;
- (2) Kata pengantar menggunakan dua spasi;
- (3) Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan daftar singkatan dan simbol (bila ada) disusun dengan menggunakan satu spasi;
- (4) Bagian awal lainnya yang tidak diuraikan diatur sebagaimana contoh pada lampiran.

2) Bagian Isi

Bagian isi dari proposal Skripsi meliputi BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV (pada penelitian *Original Research* yang menggunakan hewan coba/tanpa menggunakan subjek manusia). Sedangkan, pada penelitian yang menggunakan subjek manusia terdiri dari bagian A – CC (format protokol etik). Penulisan pada bagian ini disusun menggunakan 1 spasi. Isi atau uraiannya dibuat sejajar dengan batas tepi kiri bidang pengetikan dengan alenia pada awal kalimatnya ditulismenjorok sebanyak lima ketukan.

Format skripsi ditulis menggunakan format artikel/*manuscript* sebagai luaran hasil penelitian. Template artikel dapat diunduh melalui *website* atau dapat mengikuti template *manuscript* pada jurnal nasional atau internasional.

3) Bagian Akhir

Daftar pustaka dan lampiran merupakan bagian akhir dari proposal Skripsi. Daftar pustaka disusun menggunakan satu spasi dengan indensi gantung. Jarak antar referensi satu dengan yang lain adalah dua spasi. Lampiran disusun dengan satu spasi atau menyesuaikan bentuk atau jenis lampiran.

6.3.5 Judul dan Sub judul

1) Judul disusun tanpa singkatan dan tidak diakhiri tanda titik. Penulisan –BAB I – BAB IV‖ dan kata –A - CC‖ serta judul seluruhnya diketik menggunakan huruf kapital. Judul –BAB‖ dan –A-CC‖ diletakkan sejajar dengan penunjuk judul. Penunjuk judul dan judul dicetak tebal dan menggunakan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata (*capitalize each word*), kecuali kata penghubung dan kata depan;

2) Sub Judul diketik pada posisi sejajar dengan batas tepi kiri tanpa diakhiri tanda titik. Judul sub bab dicetak tebal dan menggunakan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata (*capitalize each word*), kecuali kata penghubung dan kata depan. Sub bab judul tidak boleh ditempatkan pada akhir halaman (kaki halaman). Sub bab judul pada –kaki halaman‖ harus diikuti minimum dua baris teks;

6.3.6 Ketentuan Lain

1) Sampul luar (*hard cover*)

Sampul luar pada naskah skripsi menggunakan warna biru tua untuk Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, warna merah muda untuk Program Studi Sarjana Kebidanan, warna krem untuk Program Studi Teknologi Laboratorium Medik, dan warna biru langit untuk Program Studi Sarjana Farmasi dengan tulisan berwarna hitam. Tulisan yang terdapat pada sampul luar ditentukan

sebagai berikut:

- (1) Judul Skripsi ditulis tepat pada margin atas menggunakan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 14, huruf kapital, maksimal terdiri dari 17 kata dengan susunan berbentuk piramida terbalik;
- (2) Keterangan jenis Karya Tulis Ilmiah menggunakan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 14, dan huruf kapital;
- (3) Lambang institusi pendidikan menggunakan ukuran 5 x 5 cm;
- (4) Identitas penulis menggunakan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12, jarak baris satu spasi;
- (5) Nama Program Studi menggunakan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 12, dan huruf kapital;
- (6) Nama Fakultas menggunakan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 12, dan huruf kapital;
- (7) Nama institusi pendidikan menggunakan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 12, dan huruf kapital;
- (8) Tahun menggunakan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12. Kalimat atau kata di atas dicetak tebal dan ditempatkan pada tengah-tengah halaman bidang pengetikan.

2) Halaman judul

Halaman judul dicetak pada kertas putih ukuran A4 80 gram dengan tulisan berwarna hitam. Tulisan yang terdapat pada halaman judul meliputi:

- (1) Judul Skripsi, ditulis tepat pada margin atas, jenis huruf *Times New Roman* ukuran 14, huruf kapital, maksimal terdiri dari 17 kata dan dicetak tebal dengan susunan berbentuk piramida terbalik;
- (2) Keterangan jenis Karya Tulis Ilmiah menggunakan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 14, huruf kapital, dicetak tebal;
- (3) Keterangan tujuan penulisan Skripsi (untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi misal pada Program Studi S1 Farmasi) menggunakan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak satu spasi;
- (4) Lambang institusi pendidikan menggunakan ukuran 5 x 5 cm;
- (5) Identitas penulis Skripsi menggunakan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12, huruf kapital, dicetak tebal dengan jarak satu spasi;

- (6) Nama Program Studi menggunakan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 12, dan huruf kapital yang dicetak tebal;
- (7) Nama Fakultas menggunakan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 12, dan huruf capital yang dicetak tebal;
- (8) Nama institusi pendidikan menggunakan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 12, dan huruf capital yang dicetak tebal;
- (9) Tahun menggunakan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 12, dan dicetak tebal.

Kalimat atau kata yang telah disebutkan di atas ditempatkan pada tengah-tengah halaman.

6.4 Enumerasi

Enumerasi pada skripsi harus digunakan secara konsisten dan tidak boleh dicampuradukkan. Enumerasi meliputi penomoran BAB I-BAB II atau A-CC, tabel, gambar, dan lampiran dengan menggunakan sistem *headings hierarchy* yaitu penulisan yang dibuat sejajar dengan batas tepi kiri bidang pengetikan.

Penomoran BAB I-BAB II atau A-CC dan judul menggunakan angka Arab dengan sistem digital hingga tiga deret digit. Digit terakhir pada penomoran deret digital yang lebih dari satu digit tidak diikuti oleh tanda baca titik. Struktur penomoran BAB I-BAB IV, A-CC dan bagian seterusnya diatur sebagai berikut:

- 1) Setiap judul bab diberi nomor sesuai urutan (BAB I, dan seterusnya hingga BAB IV atau A, B, C dan seterusnya hingga CC);
- 2) Nomor sub judul ditulis menggunakan sistem dua digit (2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya);
- 3) Nomor sub-sub judul ditulis menggunakan sistem tiga digit (4.2.1, 4.2.2 dan seterusnya);
- 4) Penomoran pada bagian lain jika sudah melebihi tiga deret digit yaitu menggunakan 1), 2), 3), dan seterusnya, kemudian (1), (2), (3), dan seterusnya.

Contoh struktur dan penomoran bab dan bagiannya dapat dilihat sebagai berikut:

(pada penelitian menggunakan hewan coba/tanpa subjek manusia)

BAB I

JUDUL

2.1 Sub Judul

2.2 Sub Judul

2.2.1 Sub-Sub Judul

1)

2)

(1)

(2)

(pada penelitian menggunakan subjek manusia)

A JUDUL

2.1 Sub Judul

2.2 Sub Judul

2.2.1 Sub-Sub Judul

1)

2)

(1)

(2)

Tabel diberi nomor dengan angka Arab dan diletakkan dua spasi di bawah bagian akhir uraian. Nomor tabel terdiri dari dua digit. Digit pertama menunjukkan nomor bab sesuai posisi tabel dan digit kedua menunjukkan nomor urut tampilnya tabel pada bab tersebut. Tabel 5.1 berarti posisi tabel berada pada bab 5 dengan nomor urut tampilan 1.

Gambar diberi nomor dengan angka Arab dan diletakkan dua spasi di bawah bagian akhir uraian. Nomor tabel terdiri dari dua digit. Digit pertama menunjukkan nomor bab sesuai posisi gambar dan digit kedua menunjukkan nomor urut tampilnya gambar pada bab tersebut. Gambar 2.3 berarti posisi tabel berada pada bab 2 dengan nomor urut 3.

6.5 Penomoran Halaman

Ketentuan-ketentuan dalam penomoran halaman, seperti halaman bagian awal, halaman judul bab, halaman teks utama, dan lain sebagainya, adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian awal Skripsi diberi nomor halaman berupa angka Romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya) dan ditempatkan di tengah halaman bagian bawah. Halaman judul tidak diberi nomor, tetapi tetap dihitung sebagai halaman i;
- 2) Bagian isi yaitu mulai BAB I atau A sampai dengan halaman terakhir daftar pustaka (CC) diberi nomor halaman berupa angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Nomor halaman ditempatkan di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali halaman pertama setiap bab yang ditulis pada tengah halaman bagian bawah;
- 3) Penomoran halaman pada lampiran merupakan kelanjutan dari nomor halaman bagian utama.

6.6 Tabel, Gambar, dan Lampiran

Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penulisan tabel, gambar, dan lampiran:

- 1) Judul dan subbab dari tabel, gambar, dan lampiran diawali dengan huruf kapital;
- 2) Judul tabel beserta nomor tabel menggunakan *Times New Roman* 12 dan ditempatkan di atas tabel dengan jarak satu spasi tanpa diakhiri dengan titik. Judul tabel diletakkan di tengah apabila hanya terdiri dari satu baris. Judul tabel yang terdiri dari dua baris ditulis dengan format menggantung (*indent*) dengan jarak antar baris yang digunakan adalah satu spasi;
- 3) Tabel disajikan di tengah, simetris dengan batas tepi kiri dan kanan bidang pengetikan. Ukuran huruf dalam tabel/gambar dapat diperkecil dari teks sebelum dan sesudahnya sampai ukuran 10 menggunakan satu spasi. Tabel disajikan tanpa garis tegak. Garis datar hanya tampak pada baris awal, di bawah judul kolom, dan baris akhir pada tabel;
- 4) Sumber tabel (khusus untuk data sekunder) diletakkan di bawah tabel yaitu setelah keterangan tabel dan menggunakan *Times New Roman* ukuran 10;
- 5) Gambar dalam naskah Skripsi dapat berupa bagan, grafik, peta, diagram, atau foto. Judul gambar beserta nomornya ditempatkan di bawah gambar dengan jarak satu spasi tanpa diakhiri dengan titik. Judul gambar beserta gambar berjarak empat spasi dari uraian sebelum dan sesudahnya;
- 6) Judul gambar diletakkan di tengah apabila hanya terdiri dari satu baris. Judul gambar yang terdiri dari dua baris ditulis dengan format menggantung (*indent*) dengan jarak antar baris yang digunakan adalah satu spasi;

- 7) Gambar diletakkan pada paragraf yang terpisah dari uraian dengan posisi tengah secara horizontal;
- 8) Sumber gambar dan keterangan (bila ada) diletakkan sebelum judul gambar menggunakan *Times New Roman* ukuran 10;
- 9) Judul lampiran beserta dengan nomornya menggunakan *Times New Roman* 12 dan ditempatkan di atas lampiran tanpa diakhiri tanda baca titik.

6.7 Penulisan Kutipan dan Referensi pada Teks Utama

Pencantuman sumber rujukan adalah salah satu bentuk tanggung jawab akademis penulis sekaligus merupakan bentuk apresiasi terhadap hal-hal yang pernah dipublikasikan, ditulis, atau disampaikan oleh pemberi informasi. Cara penulisan sumber rujukan dalam naskah terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

Kutipan langsung adalah kutipan pendapat, hasil penelitian atau hasil karya orang lain yang disajikan sama persis dengan teks asli yang dikutip. Penulisan sumber kutipan pada teks utama terdiri dari nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halaman. Penulisan sumber untuk kutipan langsung dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jika kutipan tidak lebih dari tiga baris, maka ditulis dengan jarak dua spasi dan diberi tanda petik. Contoh:

Akrom (2014:55) menyatakan bahwa -Data dikatakan memiliki distribusi normal apabila perbandingan SD/rerata memiliki nilai skor <30%

- 2) Jika kutipan mencapai lebih dari tiga baris, maka kutipan diketik sejajar dengan awal alenia baru, menggunakan jarak satu spasi, dan tanpa tanda petik. Contoh:

Menurut Parwata (2016:17), dalam pengobatan tradisional di Bali fungsi obat akan mendasari takaran/perbandingan bahan obat, sebagai berikut:

Takaran/perbandingan bahan obat didasari atas fungsi obat tersebut apakah sebagai obat dalam (oral/ masuk mulut) atau obat luar. Jika dipergunakan sebagai obat luar (kulit) maka perbandingan tiap unsurnya mempergunakan perbandingan angka 7, 9, 11 sedangkan bila dipergunakan sebagai obat dalam (masuk mulut) maka memakai perbandingan angka 1, 3, atau 5.

Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang disusun dengan menuliskan buah pikiran, hasil penelitian, karya atau pendapat seseorang (kelompok) dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah maknanya. Jarak pada kutipan tidak langsung menggunakan dua spasi (sama dengan jarak baris dalam uraian/naskah) tanpa diberi tanda kutip. Penulisan sumber untuk kutipan tidak langsung dijelaskan sebagai berikut:

- 3) Jika kutipan dituliskan dahulu, maka nama pengarang ditulis pada bagian akhir kalimat dengan menyebutkan nama keluarga/belakang pengarang diikuti oleh tanda baca koma dan tahun yang diapit oleh tanda kurung. Contoh:

Sebanyak 40–50% kematian pada populasi yang menjalani dialisis disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler (Niwa, 2010).

- 4) Nama keluarga/belakang pengarang diikuti tahun yang diapit oleh tanda kurung, jika kutipan dituliskan pada bagian akhir kalimat. Contoh:

Niwa (2010) menyatakan bahwa sebanyak 40–50% kematian pada populasi yang menjalani dialisis disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler.

- 5) Penulisan sumber rujukan dengan dua orang pengarang yaitu dengan mencantumkan nama akhir kedua pengarang menggunakan tanda hubung *-and* atau *-dan*. Contoh:

Toksin uremik berperan dalam kerusakan kardiovaskuler yang merupakan penyebab utama kematian pada penyakit ginjal kronis (Glorieux *and* Vanholder, 2011).

Smeltzer *and* Bare (2012) menyatakan bahwa tindakan hemodialisis tidak dapat merubah perjalanan alami yang mendasari penyakit ginjal dan juga tidak dapat mengembalikan fungsi ginjal secara keseluruhan.

Indonesia termasuk negara yang mengalami peningkatan prevalensi gagal ginjal kronis setiap tahunnya (Firmansyah dan Gatot, 2010).

- 6) Penulisan sumber rujukan dengan lebih dari dua orang pengarang yaitu dengan mencantumkan nama akhir pengarang pertama diikuti singkatan *-et al.* " atau dkk.

Contoh:

Hemodialisis maupun hemodiafiltrasi tidak efektif dalam membantu pembersihan serum *indoxyl sulfate* (Lin *et al*, 2011).

6.8 Penulisan Daftar Pustaka

Ketentuan umum penulisan daftar pustaka dalam Skripsi adalah sebagai berikut:

- 1) Daftar referensi harus memuat semua sumber referensi yang digunakan dalam naskah Skripsi;
- 2) Gelar pengarang tidak dicantumkan dengan keterangan tahun menggunakan empat digit;
- 3) Daftar referensi disusun berdasarkan urutan abjad menggunakan jarak satu spasi;
- 4) Penulisan daftar pustaka menggunakan *American Psychological Association Style*; APA
- 5) Penulisan sitasi dan daftar pustaka harus menggunakan perangkat lunak *referencing manager*, misalnya EndNote, Mendeley, atau Zotero.
- 6) Setiap pustaka acuan dalam daftar pustaka sedapatnya mencantumkan data bibliografi sumber informasinya selengkap mungkin. Data yang perlu dicantumkan adalah:
 - (1) Nama lengkap pengarang/penulis, editor atau lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitan pustaka tersebut;
 - (2) Judul buku/ artikel, bab/bagian dari buku atau majalah;
 - (3) Data penerbitan untuk buku/ berikut jilid, edisi, tahun terbit/penerbit, kota, dan tebal atau jumlah halaman buku;
 - (4) Data penerbitan untuk majalah adalah judul majalah, volume/tahun, nomor, tahun terbit, dan halaman artikel tersebut (yang dikutip);
- 7) Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah, dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur/pustaka yang dirujuk;

- 8) Jika penulis lebih dari dua orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan-6), dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya;
- 9) Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan *-et al.* sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya;
- 10) Beberapa contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan bentuk sumber rujukan:

(1) Buku teks:

Daugirdas, J. T., P. G. Blake, and T. S. Ing. 2007. *Handbook of Dialysis*. 4th Edition. Philadelphia. Lipincott William & Wilkins.

Hudson, J. Q. and L. D. Wanzy. 2014. Chronic Kidney Disease In *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach*. 9th Edition. The McGraw- Hill Education Inc.

Skorecki, K. 2012. Chronic Kidney Disease In *Harrison's Principles of Internal Medicine*. 8th Edition. The McGraw-Hill Companies Inc.

(2) Buku teks terjemah:

Ansel, H. C. and S. J. Prince. 2004. *Pharmaceutical Calculations: The Pharmacist's Handbook*. Lippincot Williams & Wilkins. Philadelphia.

Terjemahan Aisyah, C. dan E. Elviana. 2006. *Kalkulasi Farmasetik Panduan Untuk Apoteker* Cetakan I. EGC: Jakarta.

(3) Buku terbitan lembaga/badan/organisasi:

Indonesian Renal Registry. 2015. *8th Report of Indonesian Renal Registry 2015*. Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI). Jakarta.

(4) Artikel dalam jurnal:

Fujii, H., K. Nakai, and M. Fukagawa. 2011. Role of Oxidative Stress and Indoxyl Sulfate in Progression of Cardiovascular Disease in Chronic Kidney Disease. *Therapeutic Apheresis and Dialysis*. 15(2): 125–128.

Ohtake, T. and S. Kobayashi. 2017. Impact of Vascular Calcification on Cardiovascular Mortality in Hemodialysis Patients: Clinical Significance. Mechanisms and Possible Strategies for Treatment. *Renal Replacement Therapy*. 3(13): 1–11.

(5) Skripsi/tesis/disertasi:

Pebriarti, I. W. 2018. Hubungan Kadar Serum *Indoxyl Sulfate* dengan Lama Menjalani Hemodialisis pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik di RSD dr Soebandi. *Tesis*. Program Magister Farmasi Klinik Universitas Airlangga. Surabaya.

Sari, L. P. 2021. Hubungan Waktu Tunggu Pelayanan Resep dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. *Skripsi*. Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr Soebandi. Jember.

(6) Artikel dari internet:

Priyambodo, B. 2016. Lama Obat Bisa Digunakan Setelah Segel Terbuka. 14 Agustus 2016. www.tribunjogja.com dan <http://farmasi.ugm.ac.id>. 16 Oktober 2020 (7:11).

(7) Artikel dari majalah atau surat kabar:

Setyanto, D. B. 2020. *Asma pada Anak dan Terapi Nebulisasi Kortikosteroid*. Medisina. Edisi XXXVI. 3 Juli. Halaman 28–29. Jakarta.

(8) Berita dari majalah atau surat kabar:

Koran KOMPAS. 2021. *Menuju Kekebalan Komunitas Nusantara*. Harian Kompas. 18 Januari. Halaman 8. Jakarta.

BAB 8 PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI

7.1 Pelaksanaan Ujian

7.1.1 Sifat Ujian

Ujian skripsi/skripsi bersifat komprehensif dalam artian bahwa ujian bersifat menyeluruh selagi berkaitan dengan materi skripsi dan dilaksanakan secara lisan dan dihadiri oleh dosen pembimbing dan penguji secara bersamaan. Masing-masing dosen penguji dan pembimbing memberikan pertanyaan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

7.1.2 Kehadiran Penguji

Ujian dilaksanakan oleh suatu tim dan dapat dilangsungkan jika dihadiri dosen pembimbing utama, ketua penguji dan penguji anggota. Dosen pembimbing utama bertindak sebagai pimpinan sidang saat ujian.

7.1.3 Atribut Ujian

- 1) Peserta ujian memakai pakaian rapi dan sopan dengan ketentuan mengenakan seragam batik dan jas almamater Universitas dr. Soebandi.
- 2) Penguji memakai batik atau kemeja atau mengenakan blazer bagi wanita.

7.1.4 Prosedur Pelaksanaan Ujian

- 1) Paling lambat setengah jam sebelum ujian Skripsi berlangsung mahasiswa wajib hadir dan mempersiapkan diri;
- 2) Saat ujian berpakaian rapi, jas almamater, dan bersepatu;
- 3) Saat ujian membawa laptop sendiri dan menyiapkan *power point* untuk persentasi ujian Skripsi;
- 4) Saat ujian mahasiswa membawa *Log Book* penelitiannya;
- 5) Ujian Skripsi berlangsung $\pm$ 60 menit, 10-15 menit pertama diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mempresentasikan hal-hal pokok dari Skripsinya;
- 6) Pembimbing anggota selaku pimpinan sidang memimpin ujian Skripsi (membuka dan menutup pelaksanaan ujian);

- 7) Pimpinan sidang memberikan waktu kepada mahasiswa untuk menyajikan skripsi selama 10-15 menit;
- 8) Tim dosen penguji mengajukan pertanyaan atau komentar kepada mahasiswa setelah disilahkan oleh pimpinan sidang;
- 9) Mahasiswa disilahkan menyampaikan respon terhadap pertanyaan atau komentar dari dosen penguji;
- 10) Setelah ujian selesai mahasiswa **wajib memberikan laporan** kepada Komisi Bimbingan.

7.1.5 Penilaian Ujian

Penguji memberikan penilaian berdasarkan format yang telah disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tiap penguji memberikan hasil penilaiannya pada tiap komponen dalam bentuk angka 0—10 pada kolom nilai dalam format penilaian ujian Skripsi;
- 2) Selisih nilai yang diberikan oleh para penguji dan pembimbing tidak melebihi 15, jika lebih maka nilai tersebut harus ditinjau ulang. Tim penguji membuat kesepakatan hasil ujian secara terbuka tanpa dihadiri oleh mahasiswa;
- 3) Penguji mengisi dan memberikan format penilaian kepada pimpinan sidang. Nilai dari penguji selanjutnya direkap oleh pimpinan sidang;
- 4) Nilai akhir ujian skripsi adalah nilai rerata dari para penguji dengan pembulatan ke bawah dua desimal;
- 5) Pada ujian akhir, nilai lulus adalah A atau B. Mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 70,00 dinyatakan tidak lulus.

7.2 Pengumuman Hasil Ujian

- 1) Pengumuman hasil ujian skripsi/skripsi disampaikan oleh segera setelah ujian selesai dengan dihadiri oleh tim penguji;
- 2) Apabila ada alasan tertentu, pengumuman hasil ujian dapat ditunda atas persetujuan semua penguji;
- 3) Mahasiswa yang tidak lulus ujian akhir pada kesempatan pertama, diberi kesempatan mengulang 2 (dua) kali jika batas masa pendidikan maksimal belum terlampaui.

7.3 Perbaikan Naskah Skripsi

Perbaikan naskah Skripsi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peserta ujian yang dinyatakan lulus berkewajiban segera memperbaiki naskah skripsi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing dalam kurun waktu paling lama satu bulan;
- 2) Mahasiswa wajib menyatakan bahwa skripsinya bukan merupakan hasil plagiat yang dibuktikan dengan pemeriksaan plagiasi di LPPM Universitas dr. Soebandi dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai Rp 10.000,-

DAFTAR PUSTAKA

- Akrom. 2014. *Dasar-Dasar Evidence Based Medicine Bagi Mahasiswa Farmasi*. Pustaka Imany. Yogyakarta.
- Ansel, H. C. and S. J. Prince. 2004. *Pharmaceutical Calculations: The Pharmacist's Handbook*. Lippincot Williams & Wilkins. Philadelphia. Terjemahan Aisyah, C. dan E. Elviana. 2006. *Kalkulasi Farmasetik Panduan Untuk Apoteker* Cetakan I. EGC: Jakarta.
- Aprilyana, C. D. T. 2021. Uji Antiinflamasi dan Analgesik Ekstrak Etil Asetat Daun Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.) Pada Mencit dengan Metode Induksi Formalin. *Skripsi*. Program Studi Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi. Jember.
- Daugirdas, J. T., P. G. Blake, and T. S. Ing. 2007. *Handbook of Dialysis*. 4th Edition. Philidelphia. Lipincott William & Wilkins.
- Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 2021. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi 2020/2021*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.
- Firmansyah, M. A. dan D. Gatot. 2010. Usaha Memperlambat Perburukan Penyakit Ginjal Kronik ke Penyakit Stadium Akhir. *Cermin Dunia Kedokteran*: Jakarta.
- Fujii, H., K. Nakai, and M. Fukagawa. 2011. Role of Oxidative Stress and Indoxyl Sulfate in Progression of Cardiovascular Disease in Chronic Kidney Disease. *Therapeutic Apheresis and Dialysis*. Vol. 15(2): 125–128.
- Glorieux, G., and R. Vanholder. 2011. New Uremic Toxins-Which Solutes Should be Removed?. *Contrib Nephrol*. Vol.168: 117 – 128.
- Hermawan, I. 2019. Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metodologi. Penerbit Hidayatul Quran Kuningan. Kuningan.
- Hudson, J. Q. and L. D. Wanzy. 2014. Chronic Kidney Disease In *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach*. 9th Edition. The McGraw-Hill Education Inc.
- Indonesian Renal Registry. 2015. *8th Report of Indonesian Renal Registry 2015*. Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI). Jakarta
- Koran KOMPAS. 2021. *Menuju Kekebalan Komunitas Nusantara*. Harian Kompas. 18 Januari. Halaman 8. Jakarta.

- Lin, C.J., C. K. Chuang, H. L. Liu, T. J. Wang, H. H. Chen, F. J. Sun, and C. J. Wu. 2011. The Serum Levels of P-Cresol and Indoxyl Sulfate in Different Hemodialysis Vintage. *Journal of Clinical Medicine and Research*. Vol. 3 (8): 114 – 119.
- Mansyur, U. 2018. *Kiat dan Teknik Penulisan Skripsi Bagi Mahasiswa*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/juds7/download>. 24 Oktober 2021.
- Niwa, T.. 2010. Uremic Toxicity of Indoxyl Sulfate. *Nagoya J Med Sci*. Vol. 72: 1 – 11.
- Ohtake, T. and S. Kobayashi. 2017. Impact of Vascular Calcification on Cardiovascular Mortality in Hemodialysis Patients: Clinical Significance. Mechanisms and Possible Strategies for Treatment. *Renal Replacement Therapy*. Vol. 3(13): 1–11.
- Parwata, I. M. D. 2016. *Diktat Obat Tradisional*. Laboratorium Kimia Organik FMIPA Universitas Udayana. Bali.
- Pebriarti, I. W. 2018. Hubungan Kadar Serum *Indoxyl Sulfate* dengan Lama Menjalani Hemodialisis pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik di RSD dr Soebandi. *Tesis*. Program Magister Farmasi Klinik Universitas Airlangga. Surabaya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. 28 Januari 2020. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47. Jakarta.
- Priyambodo, B. 2016. Lama Obat Bisa Digunakan Setelah Segel Terbuka. 14 Agustus 2016. www.tribunjogja.com dan <http://farmasi.ugm.ac.id>. 16 Oktober 2020 (7:11).
- Rif'ah, E. N., A. M. Wati., dan D.A. Kusumawardani, 2019. *Panduan Penulisan Ilmiah*. UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember. Jember.
- Sari, L. P. 2021. Hubungan Waktu Tunggu Pelayanan Resep dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. *Skripsi*. Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr Soebandi. Jember.
- Saukah, A., Y. Basthomi, I. A. Basuki, Efendi, N. Hidayah, W. Kamdi, A. Mukhadis, dan Suyono. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan Penelitian*. Edisi Keenam. Universitas Negeri Malang Press. Malang.
- Setyanto, D. B. 2020. *Asma pada Anak dan Terapi Nebulisasi Kortikosteroid*. Medisina. Edisi XXXVI. 3 Juli. Halaman 28–29. Jakarta.

Skorecki, K. 2012. Chronic Kidney Disease In *Harrison's Principles of Internal Medicine*. 8th Edition. The McGraw-Hill Companies Inc.

Smeltzer, S.C., and B. G. Bare. 2002. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner dan Suddarth*, 8th Edition. Vol. 1,2. Alih bahasa oleh Waluyo, A. Jakarta: EGC.

Stevani, H., 2016, Modul Bahan Ajar Cetak Farmasi Praktikum Farmakologi, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta

Vitaliati, T., I. A. Silvanasari, Y. Handayani, D. A. Susanti, F. Ekaprasetia, S. Mayasari, N. Isnawati, R. Darotin, A. E. Pranata, A. Fatarona, F. Novitasari, W. Anggitasari, E. Anggraeni. 2020. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*. STIKES dr. Soebandi Jember. Jember.

Wibowo, R., Zulfikar, H. Paramu, D. Rato, H. S. Addy, E. Sulistyaningsih, S. Bukhori, A. Tallapessy, N. D. Gianawati, Siswoyo, A. Rijadi, dan Nawiyanto, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UPT Penerbitan Universitas Jember. Jember.

Lampiran 1 Contoh Halaman Sampul

**HUBUNGAN WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP DENGAN
KEPUASAN PASIEN DI INSTALASI RAWAT JALAN**

RUMAH SAKIT X KABUPATEN JEMBER

(Tiga spasi) (Huruf Times New Roman, bold, ukuran 14, satu spasi)
(bentuk piramida terbalik)

SKRIPSI/LAPORAN TUGAS AKHIR

(Tiga spasi) (Huruf Times New Roman, bold, ukuran 14)



(Ukuran: 5cm x 5cm)

Oleh:

Lintang Purnama Sari

NIM 21050012

(Huruf Times New Roman, bold, ukuran 12, satu spasi)

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2024**

(Huruf Times New Roman, bold, ukuran 12, satu spasi)

Lampiran 2 Contoh Halaman Judul

**HUBUNGAN WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP DENGAN
KEPUASAN PASIEN DI INSTALASI RAWAT JALAN**

RUMAH SAKIT X KABUPATEN JEMBER

(Tiga spasi) (Huruf Times New Roman, bold, ukuran 14, satu spasi)
(bentuk piramida terbalik)

SKRIPSI/LAPORAN TUGAS AKHIR

(Dua spasi) (Huruf Times New Roman, bold, ukuran 14)

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar

(Huruf Times New Roman, ukuran 12, satu spasi)



(Ukuran: 5cm x 5cm)

Oleh:

Lintang Purnama Sari

NIM 21050012

(Huruf Times New Roman, bold, ukuran 12, satu spasi)

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2024**

(Huruf Times New Roman, bold, ukuran 12, satu spasi)

Lampiran 3 Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal penelitian/Hasil penelitian ini telah diperiksa oleh pembimbing
dan telah disetujui untuk mengikuti seminar proposal/seminar hasil
pada Program Studi..... Universitas dr.Soebandi

Jember,...2024

Pembimbing Utama,

(.....)

Lampiran 4 Contoh Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi/Laporan Tugas Akhir yang berjudul *Hubungan Waktu Tunggu Pelayanan Resep dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit X Kabupaten Jember* telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:

Nama :

NIM :

Hari, Tanggal :

Program Studi : Nama Program Studi.....

Universitas dr. Soebandi

Tim Penguji

Ketua Penguji,

Penguji II,

Penguji III,

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,

Universitas dr. Seobandi

Lampiran 5 Lembar Pernyataan Orisinalitas

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI/LAPORAN TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi/laporan tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau hasil tulisan orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi/laporan tugas akhir ini adalah karya orang lain atau ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi/laporan tugas akhir ini, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember,

Yang menyatakan,

(Materai 10.000)

Lampiran 6 Contoh Abstrak

ABSTRAK

Dinda Tyan Aprilyana, Candra* Aprila Fajrin, Fifteen** Weni Pebriarti, Iski***.2021. **Uji Aktivitas Analgesik Ekstrak Etil Asetat Daun Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.) pada Mencit (*Mus musculus*) dengan Metode Induksi Formalin.** Skripsi. Program Studi Sarjana Farmasi Universitas dr. Soebandi.

Daun cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) merupakan salah satu obat herbal sebagai analgesik yang terbukti mengandung senyawa golongan flavonoid dengan mekanisme kerja menghambat sintesis enzim siklooksigenase-2(COX-2) pada jalur metabolisme asam arakidonat. Tujuan penelitian ini untuk mengamati aktivitas ekstrak etil asetat daun cabai rawit sebagai analgesik dengan parameter penurunan waktu menjilat (*licking time*). Desain penelitian ini adalah *true experimental* dengan metode induksi formalin untuk memicu timbulnya rasa nyeri 30 menit setelah pemberian perlakuan. Hewan uji yang digunakan adalah 24 ekor mencit putih (*Mus musculus*) jantan yang dibagi dalam 6 kelompok yaitu kontrol normal (CMC Na0,5%), kontrol negatif (CMC Na 0,5%), kontrol positif (natrium diklofenak 3,25mg/kgBB), serta tiga kelompok perlakuan dosis ekstrak 75 mg/kgBB, 150 mg/kgBB, dan 300 mg/kgBB. Uji analgesik dengan *Mann-Whitney U* menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun cabai rawit memiliki perbedaan yang bermakna dan signifikan dengan kelompok kontrol negatif pada setiap dosisnya ($p < 0,05$). Dosis ekstrak 300mg/kgBB merupakan dosis dengan aktivitas analgesik terbaik. Ekstrak etil asetat daun cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) dapat memberikan aktivitas analgesik pada mencit yang diinduksi formalin.

Kata Kunci: *Capsicum frutescens* L., analgesik, induksi formalin

*Peneliti

**Pembimbing Utama

Lampiran 7 Contoh *Abstract*

ABSTRACT

Fawzia Khairunnisa, Salwa* Suprpti, Budi** Weni Pebriarti, Iski***.2021. **The Relationship Between Serum Level of Indoxyl Sulfate With Duration of Undergoing Hemodialysis in Patients With Chronic Kidney Disease (CKD) at Dr. Soebandi Hospital.** Essay. Pharmacy Undergraduate Study Program, University of dr. Soebandi.

Indoxyl sulfate belong to the group of protein-bound uremic toxin and accumulate as renal function declines. Several studies have demonstrated that indoxyl sulfate induce vascular inflammation, endothelial dysfunction, and vascular calcification, which may explain the association with the development of CVD and death in CKD patients. Due to its high protein bound fraction and high distribution volume resulting in low dialytic clearance, indoxyl sulfate is poorly removed by hemodialysis. Consequently, indoxyl sulfate may accumulate in the serum in patients undergo hemodialysis. This study aims to analyze the correlation between serum level of indoxyl sulfate with duration of undergoing hemodialysis in CKD patients at dr. Soebandi Hospital. This was an observational cross sectional prospective study that analyzed correlation between serum level of indoxyl sulfate with duration of undergoing hemodialysis in CKD patients. Blood samples from 54 patients who met the inclusion and exclusion criteria were taken immediately before hemodialysis. Serum levels of indoxyl sulfate were measured using ELISA Sandwich and Human Indoxyl Sulfate. The correlation analysis was perform by using Pearson correlation if data were normally distributed, or Spearman's Test if data were not normally distributed. The mean serum level of indoxyl sulfate was $37.062 \mu\text{g/mL} \pm 23.205 \mu\text{g/mL}$. The serum level of indoxyl sulfate was significantly and positively correlated with duration of hemodialysis treatment ($p < 0.05$). Our result inferred that patients undergoing longer hemodialysis may lead to higher serum level of indoxyl sulfate.

Keywords: Indoxyl Sulfate, Chronic Kidney Disease, Hemodialysis

*Author

**Main supervisor

Lampiran 8 Contoh Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Proposal Skripsi/Skripsi/Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Proposal Skripsi/Skripsi/Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Farmasi di Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi dengan judul -Uji Aktivitas Analgesik Ekstrak Etil Asetat Daun Cabai Rawit (*Capsicum frutescens L.*) pada Mencit (*Mus musculus*) dengan Metode Induksi Formalinl.

Selama proses penyusunan penulis dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Andi Eka Pranata, S.ST., S.Kep., Ns., M.Kes selaku Rektor Universitas dr. Soebandi
2. Ai Nur Zannah, S.ST., M. Keb selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi
3. apt. Dhina Ayu Susanti, S.Farm., M.Kes selaku Ketua Program Studi Sarjana Farmasi Universitas dr. Soebandi
4. Selaku pembimbing utama
5. Selaku ketua penguji
6. Selaku penguji anggota

Penulis tentu menyadari bahwa Proposal Skripsi/Skripsi/Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik serta saran dari semua pihak demi kesempurnaan Proposal Skripsi/Skripsi/Laporan Tugas Akhir ini.

Semoga Proposal Skripsi/Skripsi/Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Jember,..... 2024

Lampiran 9 Contoh Daftar Isi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 (Judul Subbab)	1
1.2 (Judul Subbab)	5
1.3 (Judul Subbab)	5
1.3.1 (Judul Sub-Subbab).....	6
1.3.2 (Judul Sub-Subbab).....	7

dan seterusnya....

Lampiran 10 Contoh Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	6
Tabel 4.1 Definisi Operasional.....	33
Tabel 5.1 Hasil Pengukuran Rata – rata Tebal Plantar dan Nilai SD.....	51
Tabel 5.2 Hasil Rata-rata % Daya Antiinflamasi Tiap Kelompok Perlakuan.....	55

Lampiran 11 Contoh Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Tumbuhan Cabai Rawit.....	7
2.2 Patofisiologi Inflamasi	12
2.3 Patofisiologi Nyeri	16
2.4 Struktur Kimia Formalin	18
2.5 Struktur Kimia Natrium Diklofenak	20
2.6 Mencit (<i>Mus musculus</i>)	25
3.1 Kerangka Konsep	27
4.1 Alur Pengolahan Data	44

Lampiran 12 Contoh Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Determinasi Tanaman.....	85
Lampiran 2 Etika Penelitian.....	86
Lampiran 3 Perhitungan Dosis Natrium Diklofenak.....	87
Lampiran 4 Tabel Hasil Pengukuran Tebal Plantar Mencit	90
Lampiran 5 Tabel Hasil Perhitungan Daya Antiinflamasi	92

Lampiran 13 Contoh Daftar Singkatan/Symbol

DAFTAR SINGKATAN

AF	: <i>Atrial Fibrillation</i>
AGEs	: <i>Advanced Glycation End-Products</i>
AV	: <i>Arterio Venous</i>
AVG	: <i>Arterio Venous Graft</i>
BUN	: <i>Blood Urea Nitrogen</i>
CCP	: <i>Calcioprotein Particle</i>
CHF	: <i>Congestive Heart Failure</i>
CRP	: <i>C-reactive Protein</i>
CYP2E1	: <i>Cytochrome P450 2E1</i>
DCM	: <i>Dilated Cardiomyopathy</i>
ELISA	: <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assays</i>
ERK	: <i>Extracellular-Signal Regulated Kinase</i>
HD	: <i>Hemodialysis</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency</i>
HUVECs	: <i>Human Vascular Endotelial Cells</i>
ICAM-1	: <i>Intercellular Adhesion Molcule-1</i>
IL-6	: <i>Interleukin-6</i>
IL-1 β	: <i>Interleukin-1β</i>

Lampiran 14 Contoh *Inform Consent*

SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

di- Desa

Kecamatan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas dr. Soebandi:

Nama :

NIM :

Akan melakukan penelitian tentang -.....
.....||

maka saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan responden pada penelitian ini.

Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i bersifat bebas artinya tanpa adanya sanksi apapun. Semua informasi dan data pribadi Bapak/Ibu/Saudara/i atas penelitian ini tetap dirahasiakan oleh peneliti.

Jika Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia menjadi responden dalam penelitian kami mohon untuk menandatangani formulir persetujuan menjadi peserta penelitian. Demikian permohonan saya, atas kerjasama dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Jember,2024

Peneliti,

Lampiran 15 Contoh Persetujuan Menjadi Responden

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Menyatakan bersedia menjadi subjek (responden) dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas dr. Soebandi yang tertanda di bawah ini:

Nama :

NIM :

Judul :

.....

Saya telah mendapatkan informasi tentang penelitian tersebut dan mengerti tujuan dari penelitian tersebut, demikian pula kemungkinan manfaat dan resiko dari keikutsertaan saya. Saya telah mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan seluruh pertanyaan saya telah dijawab dengan cara yang saya mengerti.

Saya mengerti bahwa keikutsertaan saya ini adalah suka rela dan saya bebas untuk berhenti setiap saat, tanpa memberikan alasan apapun. Dengan menandatangani formulir ini, saya juga menjamin bahwa informasi yang saya berikan adalah benar.

Jember, 2024

Responden,

Lampiran 16 Form Usulan Kepeminatan Departemen (Nama Program Studi)

	UNIVERSITAS dr. SOEBANDI FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536, E-mail : info@uds.ac.id Website : http://www.uds.ac.id
<u>FORM USULAN KEPERTEMEN (NAMA PROGRAM STUDI)</u>	
Nama Mahasiswa :	
NIM :	
Usulan Judul SKRIPSI sesuai Kepeminatan:	
Mengetahui, Komisi Bimbingan	Jember , 2024 Mahasiswa Yang Mengajukan
(.....) NIK	(.....) NIM

Lampiran 17 Contoh Form Usulan Judul Penelitian



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E_mail : info@uds.ac.id Website : <http://www.uds.ac.id>

FORM USULAN JUDUL PENELITIAN

Nama Mahasiswa :

NIM :

Usulan Judul
Penelitian :

.....

Pembimbing I :

Menyatakan bahwa Usulan Judul Penelitian (Skripsi) mahasiswa tersebut di atas telah mendapat rekomendasi dari kedua pembimbing untuk dilanjutkan menjadi proposal penelitian.

Pembimbing Utama

Tanggal

Mengetahui,
Komisi Bimbingan

Tanggal

Lampiran 18 Contoh Form Usul Studi Pendahuluan dan Penelitian



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E_mail : info@uds.ac.id Website : <http://www.uds.ac.id>

FORM USULAN STUDI PENDAHULUAN DAN PENELITIAN

Nama Mahasiswa :

NIM :

Keperluan Surat : (Studi Pendahuluan/Izin Penelitian)

Lokasi :

Waktu :

Usulan Judul :

.....

.....

.....

Mengetahui,
Komisi Bimbingan

Jember , 2024
Mahasiswa Yang Mengajukan

(.....)
NIK

(.....)
NIM

Lampiran 19 Contoh Form Persyaratan Pendaftaran Ujian Proposal



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E_mail : info@uds.ac.id Website : <http://www.uds.ac.id>

FORM PERSYARATAN PENDAFTARAN UJIAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA :

NIM :

No.	PERSYARATAN	TTD	TANGGAL
1	PEMBIMBING AKADEMIK (Lulus PKK, Target Kompetensi 75%) *Sesuai Prodi		
2	BEBAS ADMINISTRASI		
3	BEBAS AKADEMIK (SEKPRODI) (Lulus semua nilai mata kuliah 100%)		
4	Mengikuti seminar proposal minimal 3x dan menjadi <i>Opponent</i> minimal 1 x		
5	PEMBIMBING UTAMA (Minimal 8 x konsultasi)		

Jember,2024

Mahasiswa,

(.....)

Lampiran 20 Contoh Form Persyaratan Pendaftaran Ujian Sidang Skripsi



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E_mail : info@uds.ac.id Website : <http://www.uds.ac.id>

FORM PERSYARATAN

PENDAFTARAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :

NIM :

No.	PERSYARATAN	TTD	TANGGAL
1	PEMBIMBING AKADEMIK (Lulus PKK, Target Kompetensi 100%) *sesuai Prodi		
2	BEBAS ADMINISTRASI		
3	BEBAS AKADEMIK (SEKPRODI) (Lulus semua nilai mata kuliah 100% , IPK min 3,00)		
5	PEMBIMBING UTAMA (Minimal 8 x konsultasi post penelitian)		
6	TOEFL		
7	POIN SKPI		
8	Surat Uji Etik		

Jember,2024

Mahasiswa,

(.....)

Lampiran 21 Contoh Form Kehadiran Seminar Proposal



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E-mail: info@uds.ac.id Website: <http://www.uds.ac.id>

FORM KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL

NAMA MAHASISWA :

NIM :

NO.	HARI/ TANGGAL	NAMA /NIM	JUDUL PROPOSAL	TTD Pembimbing / Penguji	KETERANGAN Peserta / Opponent
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Jember, 2024

PJMK SKRIPSI,

NIK.

Lampiran 22 Contoh Form Berita Acara Pelaksanaan Ujian



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E_mail : info@stikesdrsoebandi.ac.id Website : <http://www.stikesdrsoebandi.ac.id>

BERITA ACARA PELAKSANAAN

(BAP)

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah diselenggarakan Ujian sidang PROPOSAL /SKRIPSI *) Tahun Akademik/..... di UNIVERSITAS dr. SOEBANDI, dengan uraian sebagai berikut:

Nama Mahasiswa :

NIM :

Judul Proposal/Skripsi:

Hasil : Lulus / Tidak Lulus *) dengan nilai

Catatan :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Penguji,

.....
NIDN.

Penguji II,

Penguji III,

.....
NIDN/NIK

.....
NIDN/NIK

Ket : *) Coret yang tidak perlu

Lampiran 23 Contoh Form Daftar Hadir Penguji dan Peserta Ujian



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E_mail : info@stikesdrsoebandi.ac.id Website : <http://www.stikesdrsoebandi.ac.id>

DAFTAR HADIR

PENGUJI DAN PESERTA UJIAN PROPOSAL/SKRIPSI*

PROGRAM STUDI

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Program Studi :

Tanggal Ujian :

Nama dan Tanda Tangan Peserta

Mahasiswa

.....
NIM.

Ketua Penguji,

.....
NIDN.

Penguji II,

Penguji III,

.....
NIDN/NIK

.....
NIDN/NIK

Ket : *) Coret yang tidak perlu

Lampiran 24 Parameter Penilaian Bimbingan Proposal

PARAMETER PENILAIAN BIMBINGAN PROPOSAL

NO	ASPEK YANG DINILAI	Parameter
	Perencanaan kegiatan Proposal Skripsi	Mampu menyampaikan pemikiran peneliti pada saat proses bimbingan; Kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal yang direncanakan oleh peneliti.
	Pengajuan rancangan penelitian yang sistematis	Pengajuan penelitian secara runtut/urut serta kemampuan berpikir kritis yang mengacu pada perkembangan ilmu yang ada.
3.	Penelitian berdasarkan <i>evidence based</i>	Terdapat dasar dalam menentukan masalah dengan membawa bukti/data.
4.	Pemanfaatan waktu yang efektif, efisien serta komitmen yang tinggi	Kedisiplinan, kualitas dan kontinuitas dalam proses bimbingan.
5.	Penyelesaian setiap pokok Proposal Skripsi secara tepat waktu	Terdapat <i>follow up</i> tentang pembahasan yang lalu dan selesai secara tepat waktu.

Lampiran 25 Parameter Penilaian Bimbingan Skripsi

PARAMETER PENILAIAN BIMBINGAN SKRIPSI

NO	ASPEK YANG DINILAI	Parameter
1.	Kegiatan revisi Skripsi	Ketepatan (waktu dan konten) dalam merevisi hasil penelitian skripsi; Kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal yang direncanakan oleh peneliti.
2.	Konsep berpikir kritis yang mengacu pada perkembangan penelitian terkait	Terdapat diskusi dalam proses konsultasi (2 arah).
3.	Penelitian berdasarkan <i>evidence based</i>	Terdapat dasar dalam pembahasan hasil penelitian dengan membawa bukti/data.
4.	Pemanfaatan waktu yang efektif, efisien serta komitmen yang tinggi	Kedisiplinan, kualitas dan kontinuitas dalam proses bimbingan.
5.	Penyelesaian setiap pokok Skripsi secara tepat waktu	Terdapat <i>follow up</i> tentang pembahasan yang lalu dan selesai secara tepat waktu.

Lampiran 26 Parameter Penilaian Proposal

PARAMETER PENILAIAN PROPOSAL

NO.	ASPEK YANG DINILAI	PARAMETER
Penguasaan Penulisan Proposal		
1.	Sistematika penulisan	Sesuai tata urutan yang berlaku: Bagian muka: halaman judul,, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi dan lain-lain; Bagian tubuh: pendahuluan, tinjauan teori, kerangka konseptual dan hipotesis, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kesimpulan, dan saran; Bagian belakang: daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
2.	Ketepatan penulisan bahasa, istilah, dan kutipan	Penggunaan (penggunaan tanda baca yang tepat); Diksi (pemilihan kata yang tepat); Cara menulis kutipan yang tepat.
Segi Ilmiah Tulisan Proposal		
3.	Judul	Dalam lingkup riset kesehatan; Memungkinkan untuk diteliti (penyelesaian masalah-masalah kesehatan); Memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik dan ilmu kesehatan; Orisinalitas.
4.	Urutan dalam latar belakang	Pernyataan masalah jelas; Ada skala/justifikasi masalah; Kronologis masalah (sebab dan akibat); Konsep solusi.
5.	Rumusan masalah	Ringkas, jelas, dan sederhana; Dapat diukur secara empiris dan objektif; Memungkinkan untuk dijawab/diuji secara ilmiah; Dalam bentuk kalimat pertanyaan; Tiap kata di dalam kalimat pertanyaan hendaknya definitif (tidak menimbulkan aneka tafsiran); Bahasa dan kata-katanya dimengerti oleh orang lain.
6.	Tujuan	Menjawab dari pertanyaan masalah; Ringkas, jelas, dan sederhana; Menggunakan kata kerja yang operasional; Dapat dicapai; Spesifik.
7.	Manfaat penelitian	Diungkapkan secara teoritis dan praktis; Tertulis manfaat bagi praktek dan pengembangan ilmu.
8.	Relevansi	Relevan dengan isu sekarang; Relevansi teori dengan bidang keahlian.
9.	Tinjauan teori	Semua variabel dan faktor yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dituliskan sesuai <i>update</i> terkini; Setiap pernyataan didukung oleh pustaka yang sesuai (pengarang, tahun dan nomor halaman);

		Kejelasan dalam membuat parafrase dalam setiap pernyataan.
10.	Penyusunan kerangka	Berdasarkan teori atau model secara umum; Menggambarkan semua yang tertulis pada tinjauan teori; Mengembangkan pernyataan hubungan.
11.	Perumusan hipotesis	Hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan (<i>statement</i>), bukan dalam bentuk kalimat tanya; Hipotesis harus tumbuh dari ilmu pengetahuan yang diteliti; Hipotesis harus dapat diuji; Hipotesis harus sederhana dan terbatas.
12.	Penggunaan desain penelitian dirumuskan secara baik	Pemilihan desain/rancangan penelitian yang tepat; Diuraikan desain penelitian secara teori; Diuraikan desain penelitian yang dipakai di penelitian ini; Dijelaskan pendekatan dalam proses meneliti.
13.	Kerangka kerja (<i>frame work</i>)	Pembuatan kerangka kerja yang tepat; Dijelaskan pengertian kerangka kerja; Diuraikan kegiatan yang dilakukan dari penentuan populasi sampai dengan pembuatan simpulan; Dibuat dalam diagram panah.
14.	Variabel penelitian	Variabel yang diukur dinyatakan dengan jelas; Dijelaskan variabel penelitian secara umum secara jelas; Dijelaskan variabel penelitian secara khusus secara jelas Variabel independen: Dijelaskan pengertian dari variabel independen; Diuraikan variabel yang dipakai dalam penelitian ini dengan jelas, singkat, dan padat. Variabel dependen: Dijelaskan pengertian dari variabel dependen; Diuraikan variabel yang dipakai dalam penelitian ini dengan jelas, singkat, dan padat.
15.	Definisi Operasional	Adanya definisi operasional yang jela; Adanya gambaran mengenai definisi variabel, indikator, alat ukur, dan skor dengan jelas.
16.	Desain sampling	Disebutkan populasi penelitian, sampel penelitian, dan jenis sampling yang dipakai dengan jelas Populasi Diuraikan definisi populasi dengan jelas; Diuraikan definisi populasi yang dipakai dalam penelitian ini (apa, siapa, di mana, dan kapan penelitian akan diambil); Diuraikan kurun waktu secara jelas atau besar populasi yang akan diambil. Sampel Diuraikan definisi sampel dengan jelas; Diuraikan sampel yang dipakai dalam penelitian ini; Diuraikan kriteria pengambilan sampel. Sampling Dijelaskan pengertian sampling; Ditentukan sampling yang dipakai dengan benar.

17.	Pengumpulan dan Analisa data	Dijelaskan pengumpulan dan pengolahan data yang tepat; Dijelaskan piranti yang digunakan untuk menganalisa (manual atau digital); Dijelaskan uji statistik yang digunakan; Dijelaskan pembacaan hasil uji.
18.	Etik penelitian	Penulisan <i>ethical clearance</i> minimal ada surat persetujuan responden, <i>anonymity</i> , dan <i>confidentiality</i> .
19.	Keterbatasan	Dituliskan keterbatasan (<i>sampling desain, instrument, dan feasibility</i>).
20	Penggunaan kepustakaan	Konsisten dengan model penulisan pustaka yang digunakan (misal <i>Harvard</i>); Pustaka diambil dari tahun terbit maksimal 10 tahun terakhir; Pustaka yang dianjurkan adalah jurnal-jurnal hasil penelitian terbaru.
Penyajian Proposal		
21	Penggunaan media dalam penyajian	Tampilan menarik, sederhana, mudah dibaca dan mudah dipahami; Untuk proposal jumlah slide 7-10.
22	Kewibawaan	<i>Softskill</i>
23	Penyampaian dengan lugas dan mudah dimengerti	Berbicara dengan jelas; Menyampaikan materi mudah dipahami oleh orang lain.
24	Relevansi penyajian dengan karya tulis ilmiah	Kesamaan antara yang disajikan/presentasi sama dengan yang ditulis/paper.
25	Kemampuan menjawab dengan rasional, ilmiah, dan berdasarkan <i>evidence based</i>	Mampu menjawab dengan tepat secara ilmiah; Mampu menjawab berdasarkan bukti (<i>evidence based</i>).
26	Terbuka dengan masukan yang konstruktif dan mengintegrasikan dalam karyanya	Mampu menerima fakta baru secara terbuka; Menerima pendapat lain secara kritis; Mampu menerima fakta baru secara terbuka.
27	Komunikasi yang efektif dan efisien	Mampu dalam menekankan beberapa hal yang penting; Berkomunikasi atau dialog dengan benar; Mampu menarik perhatian penguji untuk mendengarkan hasil karyanya.
28	Bertanggung jawab dengan hasil karya ilmiahnya	Plagiat

Lampiran 27 Parameter Penilaian Skripsi

PARAMETER PENILAIAN SKRIPSI

NO.	ASPEK YANG DINILAI	PARAMETER
Penguasaan Penulisan Skripsi		
1.	Sistematika penulisan	Sesuai tata urutan yang berlaku: Bagian muka: halaman judul, halaman pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak dan lain-lain; Bagian tubuh: pendahuluan, tinjauan teori, kerangka konseptual dan hipotesis, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kesimpulan, dan saran; Bagian belakang: daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
2.	Ketepatan penulisan bahasa, istilah, dan kutipan	Pungtuasi (penggunaan tanda baca yang tepat); Diksi (pemilihan kata yang tepat); Cara menulis kutipan yang tepat.
Segi Ilmiah Tulisan Skripsi		
3.	Judul	Dalam lingkup riset kesehatan; Memungkinkan untuk diteliti (penyelesaian masalah-masalah kesehatan); Memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik dan ilmu kesehatan; Orisinalitas.
4.	Urutan dalam latar belakang	Pernyataan masalah jelas; Ada skala/justifikasi masalah; Kronologis masalah (sebab dan akibat); Konsep solusi.
5.	Rumusan masalah	Ringkas, jelas, dan sederhana; Dapat diukur secara empiris dan objektif; Memungkinkan untuk dijawab/diuji secara ilmiah; Dalam bentuk kalimat pertanyaan; Tiap kata di dalam kalimat pertanyaan hendaknya definitif (tidak menimbulkan aneka tafsiran); Bahasa dan kata-katanya dimengerti oleh orang lain.
6.	Tujuan	Menjawab dari pertanyaan masalah; Ringkas, jelas, dan sederhana; Menggunakan kata kerja yang operasional; Dapat dicapai; Spesifik.
7.	Manfaat penelitian	Diungkapkan secara teoritis dan praktis; Tertulis manfaat bagi praktek dan pengembangan ilmu.
8.	Relevansi	Relevan dengan isu sekarang; Relevansi teori dengan bidang keahlian.
9.	Tinjauan teori	Semua variabel dan faktor yang berhubungan dengan masalah yang diteliti ditulis sesuai <i>update</i> terkini;

		Setiap pernyataan didukung oleh pustaka yang sesuai (pengarang, tahun dan nomor halaman); Kejelasan dalam membuat parafrase dalam setiap pernyataan.
10.	Penyusunan kerangka	Berdasarkan teori atau model secara umum; Menggambarkan semua yang tertulis pada tinjauan teori; Mengembangkan pernyataan hubungan.
11.	Perumusan hipotesis	Hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan (<i>statement</i>), bukan dalam bentuk kalimat tanya; Hipotesis harus tumbuh dari ilmu pengetahuan yang diteliti; Hipotesis harus dapat diuji; Hipotesis harus sederhana dan terbatas.
12.	Penggunaan desain penelitian dirumuskan secara baik	Pemilihan desain/rancangan penelitian yang tepat; Diuraikan desain penelitian secara teori; Diuraikan desain penelitian yang dipakai dipenelitian ini; Dijelaskan pendekatan dalam proses meneliti.
13.	Kerangka kerja (<i>frame work</i>)	Pembuatan kerangka kerja yang tepat; Dijelaskan pengertian kerangka kerja; Diuraikan kegiatan yang dilakukan dari penentuan populasi sampai dengan pembuatan simpulan; Dibuat dalam diagram panah.
14.	Variabel penelitian	Variabel yang diukur dinyatakan dengan jelas; Dijelaskan variabel penelitian secara umum secara jelas; Dijelaskan variabel penelitian secara khusus secara jelas Variabel independen: Dijelaskan pengertian dari variabel independen; Diuraikan variabel yang dipakai dalam penelitian ini dengan jelas, singkat, dan padat. Variabel dependen: Dijelaskan pengertian dari variabel dependen; Diuraikan variabel yang dipakai dalam penelitian ini dengan jelas, singkat, dan padat.
15.	Definisi Operasional	Adanya definisi operasional yang jelas; Adanya gambaran mengenai definisi variabel, indikator, alat ukur, dan skor dengan jelas.
16.	Desain sampling	Disebutkan populasi penelitian, sampel penelitian, dan jenis sampling yang dipakai dengan jelas Populasi Diuraikan definisi populasi dengan jelas; Diuraikan definisi populasi yang dipakai dalam penelitian ini (apa, siapa, di mana, dan kapan penelitian akan diambil); Diuraikan kurun waktu secara jelas atau besar populasi yang akan diambil. Sampel Diuraikan definisi sampel dengan jelas; Diuraikan sampel yang dipakai dalam penelitian ini; Diuraikan kriteria pengambilan sampel. Sampling Dijelaskan pengertian sampling; Ditentukan sampling yang dipakai dengan benar.

17.	Pengumpulan dan Analisa data	Dijelaskan pengumpulan dan pengolahan data yang tepat; Dijelaskan piranti yang digunakan untuk menganalisa (manual atau digital); Dijelaskan uji statistik yang digunakan; Dijelaskan pembacaan hasil uji.
18.	Etik penelitian	Penulisan <i>ethical clearance</i> minimal ada surat persetujuan responden, <i>anonymity</i> , dan <i>confidentiality</i> .
19.	Keterbatasan	Dituliskan keterbatasan (<i>sampling desain, instrument, dan feasibility</i>).
20.	Kemampuan menuliskan hasil penelitian	Ada data umum (karakteristik tempat penelitian dan karakteristik responden yang diteliti); Ada data khusus sesuai dengan tujuan penelitian; Analisa data berdasarkan hasil (mencari data yang menonjol/menyimpang); Hanya menjelaskan <i>what</i> (tidak ada penjelasan <i>why</i> dan <i>how</i>).
21.	Kemampuan dalam pembahasan	Menganalisa makna penelitian dihubungkan dengan tujuan penelitian (menjelaskan <i>why</i> dan <i>how</i>); Penulisan mengandung unsur: fakta (hasil penelitian), opini (pendapat peneliti) dan teori (pustaka yang mendukung opini peneliti); Isi tulisan disesuaikan dengan tujuan khusus penelitian.
22.	Kemampuan dalam menarik kesimpulan dan saran	Kesimpulan ditulis untuk menjawab tujuan penelitian; Saran ditulis berdasarkan hasil dan pembahasan; Ringkas dan jelas (dengan meminimalkan penulisan angka-angka hasil uji statistik).
23.	Penggunaan kepustakaan	Konsisten dengan model penulisan pustaka yang digunakan (misal <i>Harvard</i>); Pustaka diambil dari tahun terbit maksimal 10 tahun terakhir; Pustaka yang dianjurkan adalah jurnal-jurnal hasil penelitian terbaru.
Penyajian Skripsi		
24	Penggunaan media dalam penyajian	Tampilan menarik, sederhana, mudah dibaca dan mudah dipahami; Untuk KTI jumlah slide 9 -12.
25	Kewibawaan	<i>Softskill</i>
26	Penyampaian dengan lugas dan mudah dimengerti	Berbicara dengan jelas; Menyampaikan materi mudah dipahami oleh orang lain.
27	Relevansi penyajian dengan karya tulis ilmiah	Kesamaan antara yang disajikan/presentasi sama dengan yang ditulis/paper
28	Kemampuan menjawab dengan rasional, ilmiah, dan berdasarkan <i>evidence based</i>	Mampu menjawab dengan tepat secara ilmiah; Mampu menjawab berdasarkan bukti (<i>evidence based</i>).
29	Terbuka dengan masukan yang konstruktif dan	Mampu menerima fakta baru secara terbuka; Menerima pendapat lain secara kritis;

	mengintegrasikan dalam karyanya	Mampu menerima fakta baru secara terbuka.
30	Komunikasi yang efektif dan efisien	Mampu dalam menekankan beberapa hal yang penting; Berkomunikasi atau dialog dengan benar; Mampu menarik perhatian penguji untuk mendengarkan hasil karyanya.
31	Bertanggung jawab dengan hasil karya ilmiahnya	Plagiat

Lampiran 28 Contoh Form Penilaian Bimbingan Proposal



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E_mail : info@uds.ac.id Website : <http://www.uds.ac.id>

PENILAIAN BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Peserta :
 NIM :
 Tanggal Ujian :
 Judul Skripsi :

NO	ASPEK YANG DINILAI	Nilai	
		Maksimal	Skor
1.	Perencanaan kegiatan Proposal Skripsi	20	
2.	Pengajuan rancangan penelitian yang sistematis	20	
3.	Penelitian berdasarkan <i>evidence based</i>	20	
4.	Pemanfaatan waktu yang efektif, efisien serta komitmen yang tinggi	20	
5.	Penyelesaian setiap pokok Proposal Skripsi secara tepat waktu	20	
Jumlah Nilai		100	

Keterangan:

A $\geq$ 80

AB = 75 – 79,9

B = 70 – 74,9

Batas nilai kelulusan adalah 70 (B)

Jember,2024
 Pembimbing Utama

NIDN/NIK

Lampiran 29 Contoh Form Penilaian Bimbingan Hasil Skripsi



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E_mail : info@uds.ac.id Website : <http://www.uds.ac.id>

PENILAIAN BIMBINGAN HASIL SKRIPSI

Nama Peserta :
NIM :
Tanggal Ujian :
Judul Skripsi :
.....

NO	ASPEK YANG DINILAI	Nilai	
		Maksimal	Skor
1.	Kegiatan revisi Skripsi	20	
2.	Konsep berpikir kritis yang mengacu pada perkembangan penelitian terkait	20	
3.	Penelitian berdasarkan <i>evidence based</i>	20	
4.	Pemanfaatan waktu yang efektif, efisien serta komitmen yang tinggi	20	
5.	Penyelesaian setiap pokok Skripsi secara tepat waktu	20	
Jumlah Nilai		100	

Keterangan:

A $\geq$ 80

AB = 75 – 79,9

B = 70 – 74,9

Batas nilai kelulusan adalah 70 (B)

Jember,2024

Pembimbing Utama

NIDN/NIK

Lampiran 30 Contoh Form Nilai Ujian Seminar Proposal



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E_mail : info@uds.ac.id Website : <http://www.uds.ac.id>

NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL

Nama Peserta :
 NIM :
 Tanggal Ujian :
 Judul Skripsi :

NO	ASPEK YANG DINILAI	Nilai	
		Maksimal	Skor
Penulisan Proposal			
1	Sistematika penulisan	10	
2	Ketepatan penggunaan bahasa dan istilah	10	
Segi Ilmiah Tulisan Proposal			
3	Judul dan latar belakang penelitian	10	
4	Ketepatan menuliskan tinjauan teori dan kepustakaan	10	
5	Penyusunan kerangka konseptual dan hipotesis	10	
6	Penggunaan metodologi penelitian yang tepat	10	
Penyajian Proposal			
7	Penggunaan media dalam penyajian	10	
8	Penyampaian dengan Lugas dan mudah dimengerti	10	
9	Kemampuan menjawab dengan rasional, ilmiah, dan berdasar evidence based	10	
10	Terbuka dengan masukan yang konstruktif dan mengintegrasikan dalam karyanya	10	
Jumlah Nilai		100	

Keterangan :

A $\geq$ 80

AB = 75 – 79,9

B = 70 – 74,9

Batas nilai kelulusan adalah 70 (B)

Jember,2024
 Ketua Penguji/Penguji II/Penguji III*

 NIDN/NIK

Lampiran 35 Contoh Form Nilai Akhir Proposal Skripsi



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E_mail : info@uds.ac.id Website : <http://www.uds.ac.id>

NILAI UJIAN SIDANG SKRIPSI

Nama Peserta :

NIM :

Tanggal Ujian :

Judul Skripsi :

.....

NO	ASPEK YANG DINILAI	Nilai	
		Maksimal	Skor
Penulisan Skripsi			
1	Sistematika penulisan	10	
2	Ketepatan penggunaan bahasa dan istilah	10	
Segi Ilmiah Tulisan Skripsi			
3	Kemampuan menuliskan hasil penelitian	10	
4	Kemampuan dalam pembahasan	10	
5	Kemampuan dalam menarik kesimpulan dan saran	10	
6	Penggunaan kepustakaan	10	
Penyajian Skripsi			
7	Penggunaan media dalam penyajian	10	
8	Penyampaian dengan Lugas dan mudah dimengerti	10	
9	Kemampuan menjawab dengan rasional, ilmiah, dan berdasar evidence based	10	
10	Terbuka dengan masukan yang konstruktif dan mengintegrasikan dalam karyanya	10	
Jumlah Nilai		100	

Keterangan:

A ≥ 80

AB = 75 – 79,9

B = 70 – 74,9

Batas nilai kelulusan adalah 70 (B)

Jember,2024
Ketua Penguji/Penguji II/Penguji III*

NIDN/NIK

Lampiran 35 Contoh Form Nilai Akhir Proposal Skripsi



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr. Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax: (0331) 483536,

E-mail : info@uds.ac.id Website : <http://www.uds.ac.id>

NILAI AKHIR PROPOSAL SKRIPSI

PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

Nama :

NIM :

Judul :

Ketua Penguji :

Pembimbing Utama :

Pembimbing Anggota :

PENILAIAN	Nilai
Bimbingan Proposal	
Seminar Proposal	
Total Nilai	 / 2
NILAI AKHIR	
NILAI MUTU	

Lampiran 33 Contoh Form Nilai Ujian Sidang Skripsi



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E_mail : info@uds.ac.id Website : <http://www.uds.ac.id>

NILAI AKHIR SKRIPSI

PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

Nama :

NIM :

Judul :

Penguji :

Pembimbing Utama :

Pembimbing Anggota :

PENILAIAN	Nilai
Bimbingan Skripsi	
Sidang Skripsi	
Total Nilai	 / 2
NILAI AKHIR	
NILAI MUTU	

Lampiran 34 Contoh Form Lembar Konsultasi Pembimbingan Proposal Skripsi/Tugas Akhir



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr. Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0831) 483536,

E-mail: info@uds.ac.id Website: <http://www.uds.ac.id>

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI/TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI.....
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul :
.....

No	Tanggal	Materi yang Diskonsultasikan dan Masukan Pembimbing	TTD Pembimbing Utama

Lampiran 35 Contoh Form Lembar Konsultasi Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr. Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0831) 483536,

E-mail: info@uds.ac.id Website: <http://www.uds.ac.id>

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI/TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI.....
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul :
.....

No	Tanggal	Materi yang Diskonsultasikan dan Masukan Pembimbing	TTD Pembimbing Utama

Lampiran 36 Contoh Form Surat Permohonan Izin Penggunaan
Laboratorium



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0831) 483536,

E_mail : info@stikesdrsoebandi.ac.id Website : <http://www.stikesdrsoebandi.ac.id>

SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN LABORATORIUM

Yth. Kepala Laboratorium Terpadu
Universitas dr. Soebandi
Di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
No. HP (aktif) :
Judul Penelitian :

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi), saya bermaksud untuk memohon izin menggunakan laboratorium beserta fasilitas didalamnya sebagai berikut:

Laboratorium : (Kimia/Biologi/Teknologi/FKK)*
Waktu :

Bahwa benar saya akan menggunakan fasilitas laboratorium tersebut dengan baik, pada jam kerja sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan serta akan mengikuti ketentuan yang dibuat oleh laboratorium. Saya bersedia menerima konsekuensi jika saya melanggar ketentuan yang berlaku. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Hormat saya,

(.....)
NIDN.....

(.....)
NIM.....

Mengetahui,

Koordinator Laboratorium Terpadu
Universitas dr. Soebandi

Koordinator Laboratorium
Program Studi

(.....)
NIDN.....

(.....)
NIDN.....

Lampiran 37 Contoh Form Informed Consent untuk Calon Peserta Penelitian

Informed Consent

Mendapatkan Persetujuan Setelah Penjelasan: Informasi esensial untuk calon peserta penelitian (WHO-CIOMS 2016)

Judul Penelitian :
Jenis Penelitian :
Nama Peneliti :
Alamat Peneliti :
Lokasi (Tempat) :
Penelitian :

Sebelum meminta persetujuan individu untuk berpartisipasi dalam penelitian, peneliti harus memberikan informasi berikut, dalam bahasa atau bentuk komunikasi lain yang dapat dipahami individu (Lihat Pedoman 9):

1. Tujuan penelitian, metode, prosedur yang harus dilakukan oleh peneliti dan peserta, dan penjelasan tentang bagaimana penelitian berbeda dengan perawatan medis rutin (Pedoman 9);

Penelitian ini bertujuan untuk melihat manfaat dan tingkat keamanan pemberian vitamin B kompleks pada pasien GJK dengan hemodialisa.

Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 4 minggu, dimana setiap minggu anda menjalani hemodialisa sebanyak 2 kali. Pada minggu pertama, anda akan dilakukan pemeriksaan kadar homosistein awal dengan cara mengambil darah vena. Selanjutnya pada minggu kedua dan minggu keempat, anda akan dilakukan pemeriksaan kadar homosistein ulang dan pemeriksaan adanya efek samping, sehingga total pemeriksaan kadar homosistein ini adalah sebanyak 3 kali. Pada minggu keempat, anda akan diminta mengisi kuesioner yang berisi 8 buah pertanyaan terkait kualitas hidup anda selama 4 minggu terakhir.

2. Bahwa individu diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian, alasan untuk mempertimbangkan individu yang sesuai untuk penelitian, dan partisipasi tersebut bersifat sukarela (Pedoman 9);

Penyakit gagal ginjal kronik (GJK) menjadi salah satu penyakit penyumbang kecacatan di Indonesia. Pasien dengan GJK stadium akhir membutuhkan hemodialisa untuk membuang sisa metabolisme dalam darah. Pasien GJK dengan hemodialisa memiliki risiko penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasien yang lain. Hal tersebut terjadi oleh karena adanya kadar homosistein yang tinggi dalam darah pasien GJK dengan hemodialisa. Anda diminta berpartisipasi sebagai subjek karena merupakan pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis.

Lampiran 38 Contoh Form Pernyataan Persetujuan Ikut Penelitian

INFORMED CONSENT (PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai :

1. Penelitian yang berjudul “.....”
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian
4. Bahaya yang akan timbul
5. Prosedur Penelitian

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

..... 20.....

Peneliti,

Responden,

.....

.....

Saksi,

.....

*) Coret salah satu

Lampiran 39 Contoh Form Etik Penelitian Hewan Coba



UNIVERSITAS DR.SOEBANDI JEMBER
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
ETHICAL CLEARANCE
 Jalan dr. Soebandi no 99 Jember email: kepk@stikesdrsoebandi.ac.id

FORMULIR ETIK PENELITIAN HEWAN COBA

1.	Peneliti Utama (Title Unit Pelayanan) Multisenter Ya ☐ Tidak ☐
2.	Judul penelitian : EKSPERIMENTAL
3.	Subjek Hewan : ✓
4.	Perkiraan waktu penelitian yang dapat diselesaikan untuk tiap obyek : waktu penelitian untuk pengujian analgesik satu hewan uji adalah 60 menit. Mencit diadaptasi selama 7 hari sebelum penelitian.
5.	Tujuan/Prosedur : - o Research - o Antibody Production - o Animal or Veterinary Care, or Health Surveillance - o Pelatihan/Training - o Breeding
6.	Ringkasan usulan penelitian yang mencakup objektif / tujuan penelitian/ manfaat / relevansi dari hasil penelitian dan alasan / motivasi untuk melakukan penelitian (ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang bukan dokter) : Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek analgesik dari Ekstrak Metanol Daun Salam (<i>Syzygium polyanthum</i>) pada mencit. Manfaat:

Lampiran 40 Contoh Form Keterangan Kelaikan Etik

	UNIVERSITAS Dr.SOEBANDI JEMBER KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN ETHICAL CLEARANCE Jalan dr. Soebandi no 99 Jember email: kepk@stikesdrsoebandi.ac.id
KETERANGAN KELAIKAN ETIK ("ETHICAL CLEARANCE") No. / EC/KEPK - / / 20...	
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN STIKES dr. SOEBANDI JEMBER, SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA RANCANGAN PENELITIAN YANG DIUSULKAN, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PENELITIANDENGAN	
JUDUL :	
PENELITI UTAMA :	
UNIT / LEMBAGA :	
TEMPAT PENELITIAN : LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS dr. SOEBANDI	
DINYATAKAN LAIK ETIK	Jember, Ketua, <u>Rizki Fitrianingtyas, SST, MM, M.Keb</u> NIK.1987 06022 009082 006

Lampiran 41 Prisma Check List

Section/topic	#	Checklistitem	Reported on page#
TITLE			
Title	1	Identify the report as a systematic review, meta-analysis, or both.	
ABSTRACT			
Structured summary	2	Provide a structured summary including, as applicable: background; objectives; data sources; study eligibility criteria, participants, and interventions; study appraisal and synthesis methods; results; limitations; conclusions and implications of key findings; systematic review registration number.	
INTRODUCTION			
Rationale	3	Describe the rationale for the review in the context of what is already known.	
Objectives	4	Provide an explicit statement of questions being addressed with reference to participants, interventions, comparisons, outcomes, and study design (PICOS).	
METHODS			
Protocol and registration	5	Indicate if a review protocol exists, if and where it can be accessed (e.g., Web address), and, if available, provide registration information including registration number.	
Eligibility criteria	6	Specify study characteristics (e.g., PICOS, length of follow-up) and report characteristics (e.g., years considered, language, publication status) used as criteria for eligibility, giving rationale.	

Information sources	7	Describe all information sources (e.g., databases with dates of coverage, contact with study authors to identify additional studies) in the search and date last searched.	
Search	8	Present full electronic search strategy for at least one database, including any limits used, such that it could be repeated.	
Study selection	9	State the process for selecting studies (i.e., screening, eligibility, included in systematic review, and, if applicable, included in the meta-analysis).	
Data collection process	10	Describe method of data extraction from reports (e.g., piloted forms, independently, in duplicate) and any processes for obtaining and confirming data from investigators.	
Data items	11	List and define all variables for which data were sought (e.g., PICOS, funding sources) and any assumptions and simplifications made.	

Roadmap Penelitian Program Studi Ilmu Keperawatan Tahun 2021-2025

Roadmap Penelitian Pengembangan Model Pemberdayaan Remaja Putri sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi berbasis Keluarga

Tahap 1 (2021)	Tahap 2 (2022)	Tahap 3 (2023)	Tahap 4 (2024)	Tahap 5 (2025)
Pengkajian kesehatan reproduksi pada remaja putri	Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja putri berbasis Friedman	Uji Pakar Modul Pemberdayaan Remaja Putri sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi berbasis Keluarga	Uji Coba Modul Pemberdayaan Remaja Putri sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi berbasis Keluarga	Efektifitas modul pemberdayaan remaja putri terhadap kesehatan reproduksi
	Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja putri berbasis <i>sunrise model</i>			
	Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja putri berbasis teori pemberdayaan			

Roadmap Penelitian Pengembangan Model Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular pada Lansia

Tahap 1 (2021)	Tahap 2 (2022)	Tahap 3 (2023)	Tahap 4 (2024)	Tahap 5 (2025)
Pengkajian penyakit tidak menular pada lansia	Faktor-faktor yang mempengaruhi penatalaksanaan penyakit tidak menular berbasis teori komprehensif Carol Miller	Uji Pakar Modul penatalaksanaan penyakit tidak menular pada lansia	Uji Coba Modul penatalaksanaan penyakit tidak menular pada lansia	Efektifitas modul penatalaksanaan penyakit tidak menular terhadap status kesehatan lansia
	Faktor-faktor yang mempengaruhi penatalaksanaan penyakit tidak menular berbasis teori keluarga Friedman			
	Faktor-faktor yang mempengaruhi penatalaksanaan penyakit tidak menular berbasis teori <i>protection motivation</i> Roger			

Roadmap Penelitian Pengembangan Sekolah Gawat Darurat (SEGAAR)

Tahap 1 (2021)	Tahap 2 (2022)	Tahap 3 (2023)	Tahap 4 (2024)	Tahap 5 (2025)
Pengkajian Sekolah Gawat Darurat di kabupaten Jember	Pengembangan Sistem informasi terintegrasi sekolah gawat darurat	Pengembangan modul sekolah gawat darurat	Uji pakar modul dan system informasi sekolah gawat darurat	Produksi modul dan system informasi sekolah gawat darurat
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan siswa tentang <i>First Aid</i>	Pengembangan kurikulum <i>First Aid</i> pada siswa SD	Pengembangan media teknologi pembelajaran <i>First Aid</i> pada siswa SD	Uji pakar modul dan medi teknologi pembelajaran <i>First Aid</i> pada siswa SD	Efektifitas pengembangan Sekolah Gawat Darurat sebagai upaya peningkatan <i>By Stander First Aid</i> di tingkat SD
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan siswa tentang <i>CPR</i>	Pengembangan kurikulum <i>First Aid</i> pada siswa SMP	Pengembangan media teknologi pembelajaran <i>First Aid</i> pada siswa SMP	Uji pakar modul dan media teknologi pembelajaran <i>First Aid</i> pada siswa SMP	Efektifitas pengembangan Sekolah Gawat Darurat sebagai upaya peningkatan <i>By Stander First Aid</i> di tingkat SMP
	Pengembangan kurikulum <i>First Aid</i> pada siswa SMA	Pengembangan media teknologi pembelajaran <i>First Aid</i> pada siswa SMP	Uji pakar modul dan media teknologi pembelajaran <i>First Aid</i> pada siswa SMA	Efektifitas pengembangan Sekolah Gawat Darurat sebagai upaya peningkatan <i>Bystander First Aid</i> di tingkat SMA
	Pengembangan kurikulum <i>CPR</i> pada siswa SD	Pengembangan media teknologi pembelajaran <i>CPR</i> pada siswa SD	Uji pakar modul dan media teknologi pembelajaran <i>CPR</i> pada siswa SD	Efektifitas pengembangan Sekolah Gawat Darurat sebagai upaya peningkatan <i>Bystander CPR</i> di tingkat SD
	Pengembangan kurikulum <i>CPR</i> pada siswa SMP	Pengembangan media teknologi pembelajaran <i>CPR</i> pada siswa SMP	Uji pakar modul dan media teknologi pembelajaran <i>CPR</i> pada siswa SMP	Efektifitas pengembangan Sekolah Gawat Darurat sebagai upaya peningkatan <i>Bystander CPR</i> di tingkat SMP

	Pengembangan kurikulum <i>CPR</i> pada siswa SMA	Pengembangan media teknologi pembelajaran <i>CPR</i> pada siswa SMA	Uji pakar modul dan media teknologi pembelajaran <i>CPR</i> pada siswa SMA	Efektifitas pengembangan Sekolah Gawat Darurat sebagai upaya peningkatan <i>Bystander CPR</i> di tingkat SMA
				Paten Produk 1. Kurikulum First Aid di SD, SMP, SMA 2. Kuriulum <i>CPR</i> di SD, SMP, SMA 3. Modul, Video, dan Aplikasi First Aid 4. Modul, Video, dan Aplikasi <i>CPR</i>

Roadmap Penelitian Pengembangan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Holistik

Tahap 1 (2021)	Tahap 2 (2022)	Tahap 3 (2023)	Tahap 4 (2024)	Tahap 5 (2025)
Pelayanan keswadapa pada kelompok sehat jiwa; 1. <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i> 2. <i>Preschool and school age mental health</i> 3. <i>Adolescent mental health</i> 4. <i>Adult mental health</i> 5. <i>Elderly mental health</i>	Pelayanan keswadapa pada kelompok sehat jiwa; 1. <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i> 2. <i>Preschool and school age mental health</i> 3. <i>Adolescent mental health</i> 4. <i>Adult mental health</i> 5. <i>Elderly mental health</i>	Pelayanan keswadapa pada kelompok sehat jiwa; 1. <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i> 2. <i>Preschool and school age mental health</i> 3. <i>Adolescent mental health</i> 4. <i>Adult mental health</i> 5. <i>Elderly mental health</i>	Pelayanan keswadapa pada kelompok sehat jiwa; 1. <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i> 2. <i>Preschool and school age mental health</i> 3. <i>Adolescent mental health</i> 4. <i>Adult mental health</i> 5. <i>Elderly mental health</i>	Pelayanan keswadapa pada kelompok sehat jiwa; 1. <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i> 2. <i>Preschool and school age mental health</i> 3. <i>Adolescent mental health</i> 4. <i>Adult mental health</i> 5. <i>Elderly mental health</i>
Pengkajian dan deteksi dini pelayanan kewaspadaan kelompok sehat jiwa. 1. <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i> 2. <i>Preschool and school age mental health</i> 3. <i>Adolescent mental health</i> 4. <i>Adult mental health</i> 5. <i>Elderly mental health</i>	Pengembangan Model berbasis keperawatan jiwa Holistik pada kelompok <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i>	Uji pakar dan FGD Pengembangan Model berbasis keperawatan jiwa Holistik pada kelompok <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i>	Efektifitas pengembangan model keperawatan kesehatan jiwa holistik pada kelompok <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i>	Pengembangan Model keperawatan kesehatan jiwa holistik berbasis media teknologi pada kelompok <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i> pada kelompok <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i>

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada kelompok sehat jiwa 1. <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i> 2. <i>Preschool and school age mental health</i> 3. <i>Adolescent mental health</i> 4. <i>Adult mental health</i> 5. <i>Elderly mental health</i>	Pengembangan Model berbasis perawatan jiwa Holistik pada kelompok <i>Preschool and school age mental health</i>	Uji pakar dan FGD Pengembangan Model berbasis perawatan jiwa Holistik pada kelompok <i>Preschool and school age mental health</i>	Efektifitas pengembangan model perawatan kesehatan jiwa holistik pada kelompok <i>Preschool and school age mental health</i>	Pengembangan Model perawatan kesehatan jiwa holistik berbasis media teknologi pada kelompok <i>Preschool and school age mental health</i>
	Pengembangan Model berbasis perawatan jiwa Holistik pada kelompok <i>Adolescent mental health</i>	Uji pakar dan FGD Pengembangan Model berbasis perawatan jiwa Holistik pada kelompok <i>Adolescent mental health</i>	Efektifitas pengembangan model perawatan kesehatan jiwa holistik pada kelompok <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i>	Pengembangan Model perawatan kesehatan jiwa holistik berbasis media teknologi pada kelompok <i>Infant Mental Health/early childhood mental health</i>
	Pengembangan Model berbasis perawatan jiwa Holistik pada kelompok <i>Adult mental health and Elderly mental health</i>	Uji pakar dan FGD Pengembangan Model berbasis perawatan jiwa Holistik pada kelompok <i>Adult mental health and Elderly mental health</i>	Efektifitas pengembangan model perawatan kesehatan jiwa holistik pada kelompok <i>Adult mental health and Elderly mental health</i>	Pengembangan Model perawatan kesehatan jiwa holistik berbasis media teknologi pada kelompok <i>Adult mental health and Elderly mental health</i>
1. Instrumen deteksi dini kesehatan jiwa 2. Publikasi jurnal nasional dan internasional	1. Pemodelan 2. Modul 3. Publikasi	1. ISBN 2. HAKI 3. Modul	1. Publikasi jurnal nasional dan internasional	1. Paten 2. Publikasi jurnal nasional dan internasional 3. HAKI 4. ISBN 5. Modul 6. Aplikasi

onal	jurnal nasio nalda ninter nasio nal			
------	--	--	--	--

Roadmap Penelitian Pengembangan Manajemen Keperawatan Berbasis Holistik Pada Praktik Mandiri Perawat

TAHAP 1 (2021)	TAHAP 2 (2022)	TAHAP 3 (2023)	TAHAP 4 (2024)	TAHAP 5 (2025)
Pengkajian fungsi manajemen dan sumber daya pada praktik mandiri perawat di Jawa Timur	Pengembangan fungsi manajemen dan sumber daya pada praktik mandiri perawat berbasis holistik	Pengembangan modul implementasi proses manajemen keperawatan berbasis holistik pada praktik mandiri perawat	Uji modul implementasi proses manajemen keperawatan berbasis holistik pada praktik mandiri perawat	Efektifitas proses manajemen keperawatan berbasis holistik pada praktik mandiri perawat
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan perawat praktik mandiri tentang dokumentasi asuhan keperawatan	Pengembangan sistem pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis 3S pada praktik mandiri perawat	Pengembangan model dokumentasi keperawatan berdasarkan 3S dalamaplikasiberbasis Komputer	Uji media teknologi model dokumentasi keperawatan berdasarkan 3S dalam aplikasi berbasis komputer	Implementasi model dokumentasi keperawatan berdasarkan 3S dalam aplikasi berbasis komputer dalam tatanan praktik mandiri perawat
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan perawat tentang penggunaan dokumentasi asuhan keperawatan berbasis 3S (SDKI, SLKI, SIKI) dalam praktik				

mandiri perawat.				
Identifikasi terapi komplementer / Complementer And Alternatife Medicine (CAM) dan Herbal dalam praktik perawat di Era Pandemi dan Post Pandemi	Potensi pengembangan keperawatan holistik (Komplementer dan Herbal) di Era pandemi dan post pandemi	Pengembangan modul keperawatan holistik (Komplementer dan Herbal) di Era pandemi dan post pandemi	Uji publik modul	Implementasi modul keperawatan holistik (Komplementer dan Herbal) dan Evaluasi
				PATEN PRODUK: 1. Modul manajemen keperawatan berbasis holistik dalam tatanan praktik mandiri perawat 2. Aplikasi dokumentasi keperawatan berdasarkan 3S berbasis komputer pada praktik mandiri perawat. 3. Modul keperawatan holistik (Komplemente r dan Herbal) di Era pandemi dan post pandemi

Roadmap Penelitian Pengembangan Dasar Keperawatan dan Profesionalitas Mahasiswa Keperawatan UDS Dalam Meningkatkan Pelayanan Keperawatan

TAHAP 1 (2021)	TAHAP 2 (2022)	TAHAP 3 (2023)	TAHAP 4 (2024)	TAHAP 5 (2025)
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku caring mahasiswa keperawatan	Pengembangan perilaku caring mahasiswa berbasis teori	Pelatihan caring pada mahasiswa keperawatan	Diskusi pakar terkait perilaku caring mahasiswa	Modul perilaku caring mahasiswa
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dokumentasi keperawatan berbasis 3 S (SDKI, SLKI, SIKI) pada mahasiswa keperawatan	Pengembangan dokumentasi keperawatan berbasis 3S pada mahasiswa keperawatan berbasis teori	Pelatihan dokumentasi keperawatan berbasis 3S pada mahasiswa keperawatan	Diskusi pakar terkait dokumentasi keperawatan berbasis 3S pada mahasiswa keperawatan	Modelasuhan keperawatan berbasis 3S (SDKI, SLKI, SIKI) pada nursing education dalam aplikasi berbasis komputer
Identifikasi masalah perkembangan ilmu dasar keperawatan	Pengembangan bahan ajar ilmu dasar keperawatan meliputi Komponen sel dan jaringan, Biomekanik, Karbohidrat, Lipid, Protein serta Anatomi Fisiologi)	Pengembangan modul ilmu dasar keperawatan meliputi Komponen sel dan jaringan, Biomekanik, Karbohidrat, Lipid, Protein serta Anatomi Fisiologi)	Diskusi/ Uji pakar modul ilmu dasar keperawatan meliputi Komponen sel dan jaringan, Biomekanik, Karbohidrat, Lipid, Protein serta Anatomi Fisiologi)	Implementasi penyebab dan mekanisme sel serta alternative penyelesaiannya (Eksposure dari radikal bebas, Farmakokinetik dan Farmakodinamik)
				PATEN PRODUK: 1. Modul perilaku caring mahasiswa kepada diri, teman sejawat, lingkungan akademisi dan klien 2. Aplikasi dokumentasiasuhan keperawatan berbasis 3S (SDKI, SLKI, SIKI) pada nursing education dalam aplikasi berbasis komputer

				3. Modul dan bahan ajar ilmu dasar keperawatan
--	--	--	--	--

Roadmap Penelitian Kampung Tangguh Gizi

Tahap 1 (2021)	Tahap 2 (2022)	Tahap 3 (2023)	Tahap 4 (2024)	Tahap 5 (2025)
Gambaran prevalensi stunting di Kabupaten Jember	Model pengendalian faktor resiko stunting pada anak	Pemberdayaan keluarga berbasis Family Centered Care tentang Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)	Efektivitas Pemberdayaan keluarga berbasis Family Centered Care tentang Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)	Efektivitas aplikasi deteksi dini stunting bagi kader kesehatan di Kampung Tangguh Gizi
Analisis faktor yang mempengaruhi kejadian stunting di Kabupaten Jember	Peran petugas kesehatan dalam upaya pengendalian stunting	Pengembangan modul deteksi dini stunting	Uji pakar modul deteksi dini stunting	Produksi poster daily menu for stunting catch up
Gambaran pengetahuan orang tua tentang stunting	Evaluasi pelaksanaan skrining status gizi di Kabupaten Jember	Pemberdayaan kader kesehatan dalam deteksi dini stunting	Evaluasi pemberdayaan kader kesehatan dalam deteksi dini stunting	
Gambaran pengetahuan kader tentang deteksi dini keterlambatan pertumbuhan		Pengembangan modul sadar gizi dengan inovasi kearifan pangan lokal	Uji pakar modul sadar gizi dengan inovasi kearifan pangan lokal	
		Pengembangan aplikasi deteksi dini stunting bagi kader kesehatan	Uji pakar aplikasi deteksi dini stunting bagi kader kesehatan	
		Pengembangan poster daily menu for stunting catch up		Paten Produk: 1. Modul sadar gizi 2. Modul deteksi dini stunting 3. Aplikasi deteksi dini stunting 4. Poster daily menu for stunting catch up

Roadmap Penelitian Pengembangan Kampung Siaga Kanker Cervix

Tahap 1 (2021)	Tahap 2 (2022)	Tahap 3 (2023)	Tahap 4 (2024)	Tahap 5 (2025)
Gambaran Pengetahuan WUS tentang Ca Cervix di Kab Jember	Cakupan pelaksanaan IVA test di Kab Jember	Pengembangan media Teknologi Audio Visual promosi kesehatan tentang Ca Cervix	Uji pakar modul promosi kesehatan berbasis FCMC (Family Center Maternity care)	Produksi modul promosi kesehatan berbasis FCMC (Family Center Maternity care)
Gambaran Pengetahuan WUS tentang deteksi dini Ca Cervix dengan metode IVA test	Peran Petugas Kesehatan dalam upaya pencegahan Ca Cervix	Pengembangan media Teknologi Audio Visual promosi kesehatan tentang IVA test	Efektivitas promosi kesehatan menggunakan media Teknologi Audio Visual tentang IVA test	Penerapan promosi kesehatan menggunakan media Teknologi Audio Visual tentang IVA test di kampung Siaga Kanker Cervix
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi WUS dalam pemeriksaan IVA test	Evaluasi pelaksanaan pemeriksaan IVA test di Kab Jember	Pengembangan modul promosi kesehatan berbasis FCMC (Family Center Maternity care)	Evaluasi efektivitas Implementasi SGD dalam meningkatkan motivasi WUS dalam pemeriksaan IVA test	Penerapan modul promosi kesehatan berbasis FCMC (Family Center Maternity care) pada tenaga kesehatan
	Upaya Peningkatan sikap WUS dalam melaksanakan Deteksi dini Ca Cervix	Implementasi SGD dalam meningkatkan motivasi WUS dalam pemeriksaan IVA test		Paten Produk 1. Modul promosi kesehatan berbasis FCMC (Family Center Maternity care) 2. Media promosi kesehatan menggunakan Teknologi Audio Visual

Roadmap Penelitian Pengembangan Pengembangan Intervensi Keperawatan pada Trend Disease Berbasis Pendekatan Holistik

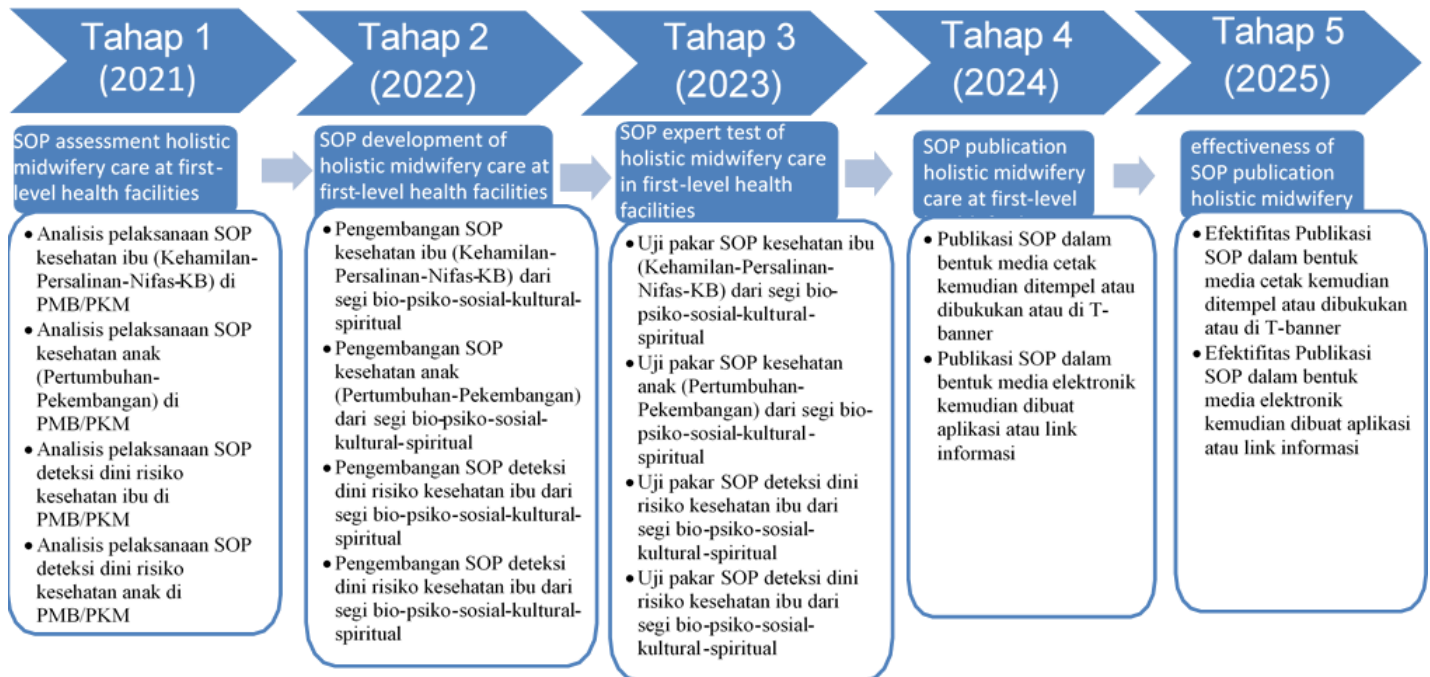
Tahap 1 (2021) Riset Dasar	Tahap 2 (2022) Teknologi	Tahap 3 (2023) Uji Coba Produk	Tahap 4 (2024) Pembakuan Produk	Tahap 5 (2025) Pengenalan dan Pengembangan
Diabetes Mellitus				
1. Pemetaan pola deteksi dini DM di masyarakat desa dan kota 2. Pemetaan persepsi dan pola pengelolaan DM di masyarakat desa dan kota 3. Perbedaan Pola Deteksi Dini Terhadap DM antara Masyarakat Desa dengan Masyarakat Kota 4. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Pengelolaan DM antara Masyarakat Desa dengan Masyarakat Kota	1. Pemetaan faktor dengan CFA (Confirmatory Factor Analysis) 2. Proyeksi faktor terhadap indikator model hingga terbentuk struktur pra model H-DM 3. Pembakuan struktur pra model H-DM melalui uji public 4. Analisa Persepsi Pasca Implementasi Pra Model H-DM pada Masyarakat Desa 5. Analisa Persepsi Pasca	1. Penyempurnaan pra model - H-DM menjadi model akhir 2. Uji expert dan pengembangan secara IT 3. Uji publik pada pengguna (sasaran DM di Desa dan Kota) 4. FGD dengan pemegang program dan caregiver terkait pandangan terhadap model H-DM 5. Persepsi dan Efektifitas Model H-DM antara Masyarakat Desa dan Kota dalam Meningkatkan Literasi DM	1. Penetapan fitur baku model <i>H-DM</i> untuk seluruh kalangan masyarakat 2. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan Kompetisi Nasional 3. Persiapan pemaparan skala besar	1. Sosialisasi lintas sektor terkait pemanfaatan model <i>H-DM</i> 2. Monitoring dan evaluasi grafik pemanfaatan model <i>H-DM</i> 3. Uji akhir model <i>H-DM</i> terhadap kesejahteraan kesehatan klien DM 4. Perubahan Kesejahteraan Kesehatan Klien DM di Pedesaan melalui Model H-DM 5. Perubahan Kesejahteraan Kesehatan Klien DM di Perkotaan melalui Model H-DM

	Implementasi Pra Model H-DM pada Masyarakat Kota			
Onkologi /Kanker				
(Penelitian Dasar) Eksplorasi masalah penyakit kronis (Cancer, Covid-19, DM) 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan kunjungan atau pemeriksaan pasien kanker kepada pelayanan kesehatan 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan kemoterapi, efek samping kemoterapi, kualitas hidup dan Recurrency kejadian kanker	1. Integrasi keperawatan holistic dalam mengatasi efek samping kemoterapi pada pasien kanker 2. Self manajemen edukasi pada pasien kanker 3. Perbandingan manajemen kesehatan pada penyintas Kanker (cancer survivor)	(Pilot study, Uji Expert, validitas reliabilitas tools) 1. Pembuatan Inovasi dalam keperawatan holistik dengan target pasien kanker (keterbaharuan intervensi keperawatan non farmakologi) 2. Penggunaan self management edukasi untuk meminimalisir efek samping kemoterapi 3. Cancer survivor supporting group berbasis Teknologi	Uji klinis dari produk hasil pilot study pada pasien kanker : Randomized control trial , Quasi experiment 1. Self management edukasi aplikasi terhadap penurunan efek samping kemoterapi 2. Cancer survivor supporting group aplikasi terhadap efek samping, koping, dan kualitas hidup pasien kanker	Output Produk → Aplikasi berbasis Teknologi, SOP, Prototype, modul, Booklet sebagai upaya meningkatkan Quality of Life , Self Management, Self Care pasien Kanker. (Penggunaan Produk Penelitian oleh Institusi rekanan dan masyarakat luas)
Hipertensi: Hypertension Awareness				
Eksplorasi kebutuhan pasien hipertensi 1. QoL 2. ADL 3. Self care ability 4. Sphyrometri data (baseline)	1. <i>Analisa faktor-faktor QoL dan ADL</i> 2. <i>Pengalaman pasien hipertensi</i> 3. <i>Need assessment</i>	Pilot study & uji expert 1. Booklet pemantauan kesehatan Hipertensi 2. Gym therapy terhadap manajemen hipertensi 3. Bekam therapy dalam	RCT & Quasi experiment : 1. Booklet pemantauan kesehatan pasien hipertensi 2. Gym therapy terhadap manajemen hipertensi 3. Bekam therapy terhadap	Paten produk dan implementasi kepada institusi mitra 1. Booklet pemantauan kesehatan Hipertensi 2. Gym therapy terhadap manajemen hipertensi

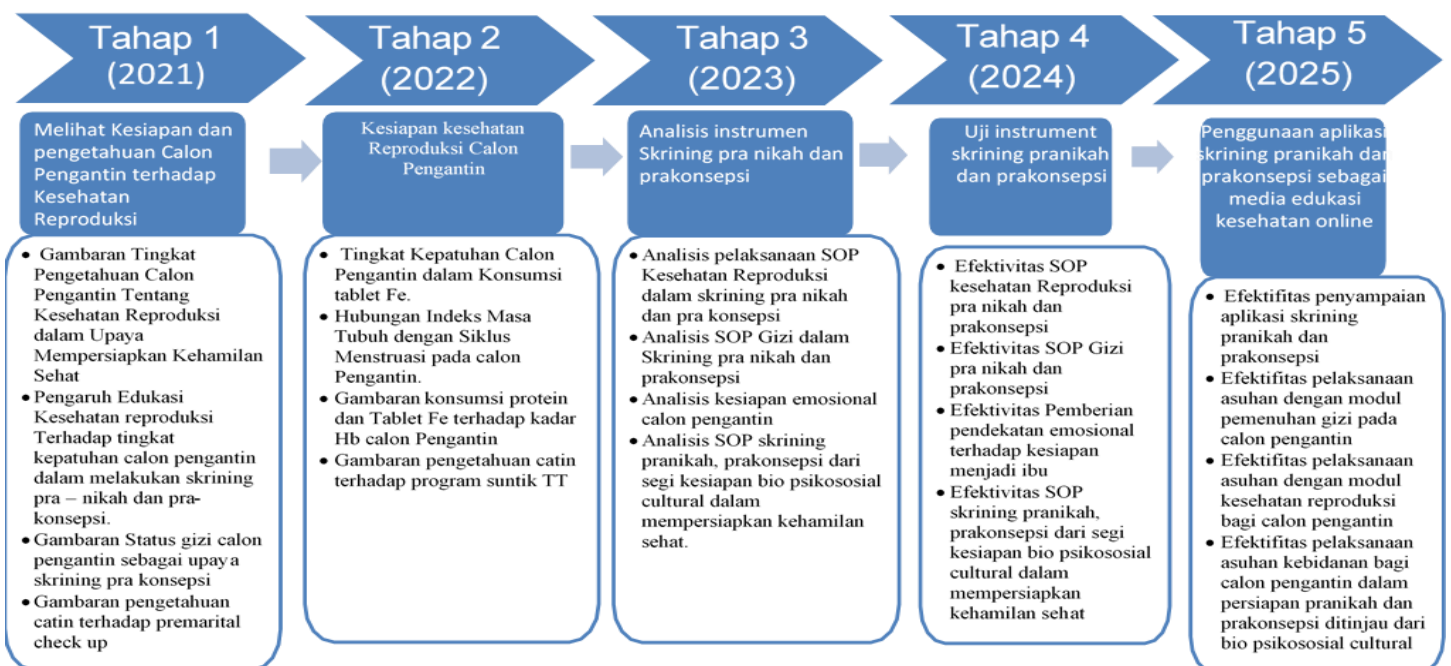
		manajemen hipertensi	manajemen hipertensi	3. SOP: Bekam therapy for terhadap manajemen hipertensi
--	--	----------------------	----------------------	---

Roadmap Penelitian Program Studi Sarjana Kebidanan Dan Profesi Bidan Tahun 2021-2025

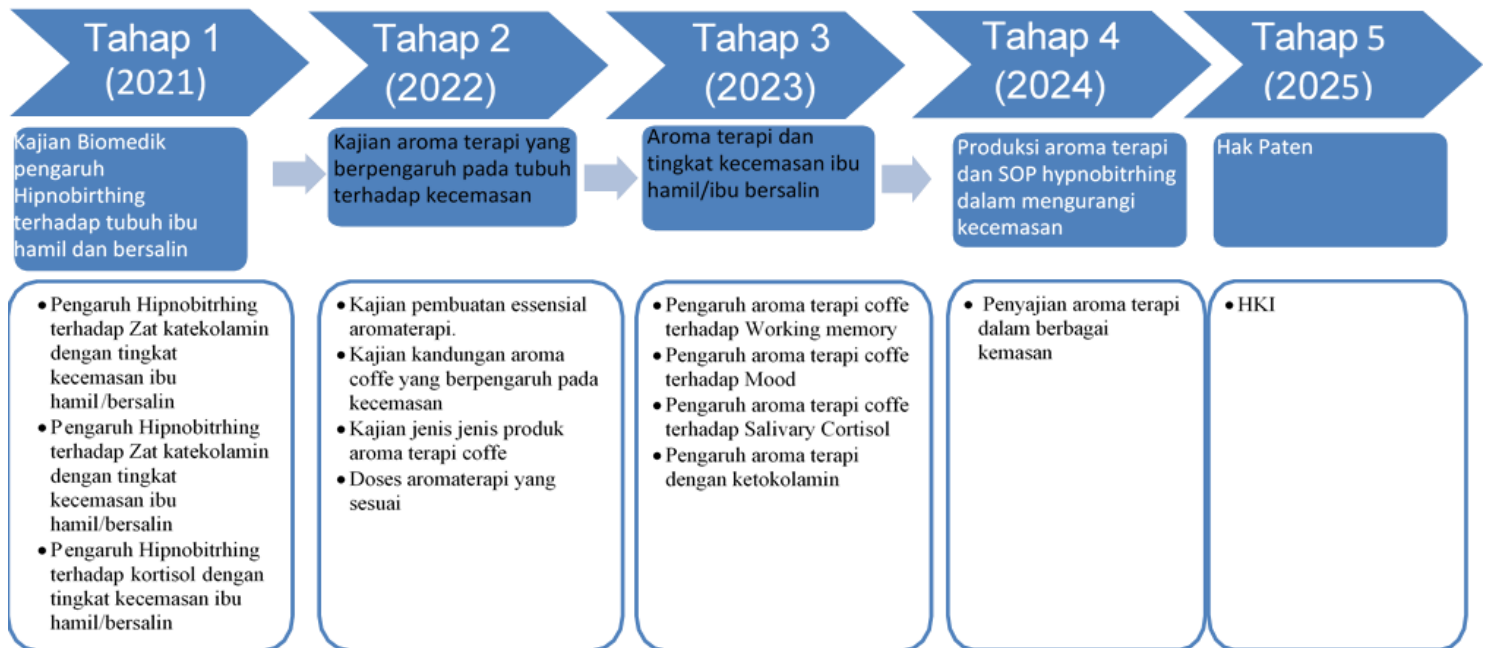
Roadmap: Making Standard Operating Procedures (SOP) for holistic midwifery care (Bio-Psycho-Social-Spiritual Care)



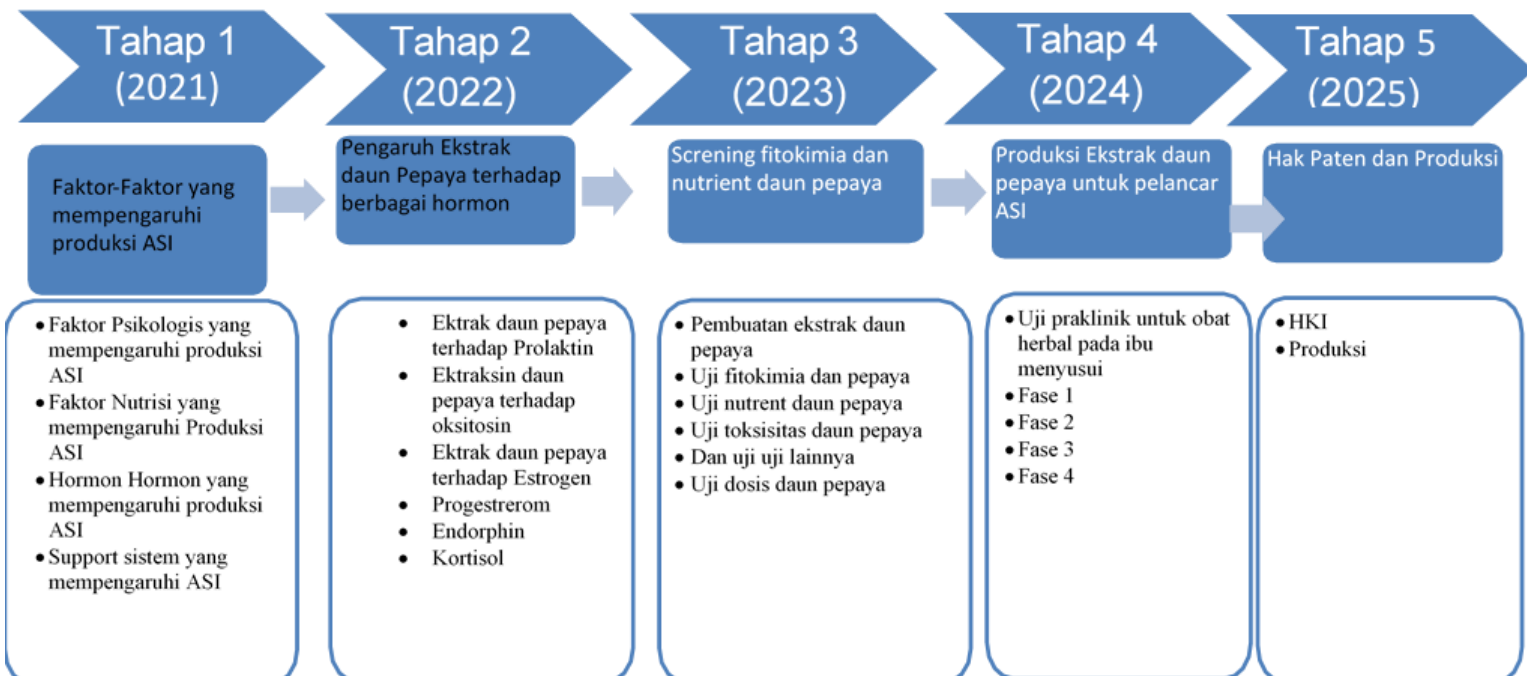
Roadmap: APLIKASI SKRINING PRA-NIKAH DAN PRA-KONSEPSI (AS2P)



Roadmap: HIPNOBIRTHING dan AROMA TERAPI DALAM MENGURANGI KECEMASAN pada IBU HAMIL dan BERSALIN



Roadmap: Ekstrak DAUN PEPAYA untuk memperlancar Produksi ASI



Roadmap Penelitian Program Studi Sarjana Farmasi Tahun 2021-2025

GRAND DESIGN RESEARCH PENGEMBANGAN BAHAN ALAM LOKAL SEBAGAI ANTIDIABETES

TAHUN					
2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026
Kajian Skrining awal	Uji aktivitas in vitro	Uji aktivitas In vivo	Uji toksisitas	Optimasi sediaan	Paten
Pemilihan bahan alam lokal sebagai kandidat antidiabetes	uji aktivitas in vitro antiamilase	uji aktivitas antidiabetes in vivo tanaman terpilih	uji toksisitas akut	optimasi formula sediaan	Sediaan obat antidiabet es
Kajian skrining fitokimia					
Penetapan senyawa marker	uji aktivitas in vitro alpha glukosidase		LD50	evaluasi sifat fisik sediaan	
Penetapan aktivitas antioksidan in vitro			Pengamatan hitopatologi organ		

PENGEMBANGAN TANAMAN SEBAGAI ANTIMIKROBA

TAHUN					
2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026
Eksplorasi Tanaman	Pengujian Antimikroba	Analisis dan Uji Karakteristik Sediaan	Formulasi dan Uji Mutu Fisik	Uji Mutu Fisik dan Karakteristik Lanjutan	Target
Eksplorasi tanaman yang berkhasiat obat	Pengujian efektivitas atau aktivitas antimikroba	Analisis komponen senyawa kimia tanaman menggunakan GCMS-MS/ LCMS-MS/ HPLC dll	Formulasi produk sediaan gel, krim, salep	Pengujian aktivitas invivo	Sediaan Herbal antimikroba
Identifikasi senyawa metabolit sekunder	Penggunaan beberapa metode ekstraksi	Uji karakteristik sediaan nano partikel	Uji evaluasi sediaan, Uji mutu fisik sediaan nano	Uji stabilitas sediaan	

(pengujian secara kualitatif atau kuantitatif)			partikel		
Penggunaan beberapa metode ekstraksi		Uji penentuan nilai indeks polidispersi	Substitusi bahan exipien pada formula	Uji sediaan semisolid nanopartikel terstandar	

GRAND DESAIGN RESEARCH PENGEMBANGAN SKINCARE BERBASIS TANAMAN LOKAL

TAHUN					
2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026
Eksplorasi	Uji <i>Skin-Aging</i> awal	Uji antimikroba	Uji enzimatis <i>Skin-Aging</i>	Formulasi	Paten
Optimasi metode ekstraksi dan pelarut	Fraksinasi	Bakteri : <i>Propionibacterium acnes</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , dan <i>Staphylococcus epidermidis</i>	pengujian enzimatis antielastase, antikolagenase dan antitirosinase	Optimasi formula sediaan	<i>Produk skincare</i>
Pengujian total fenol, total flavonoid, total alkaloid	Lanjutan : anti oksidan (FRAP, ABTS, <i>Beta caroten bleaching assay</i>)			Karakterisasi sediaan	
Standarisasi spesifik dan non spesifik	Uji <i>Skin aging</i> awal : <i>SPF</i> , <i>Eritema</i> , <i>Pigmentasi</i>	Jamur : <i>Candida albicans</i> , <i>Malassezia furfur</i>		Uji <i>skin anallizer</i>	
Skrining awal : aktivitas antioksidan DPPH				Uji toksisitas	

GRAND DESIGN RESEARCH "COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AND THERAPY"

TAHUN					
2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026
Kajian Umum	Potensi dan Penerimaan CAMT	Evaluasi tentang penggunaan CAMT di masyarakat	Evaluasi tentang Penggunaan CAMT di Pelayanan Kesehatan	Desain modul	Paten
Studi etnobotani/etnofarmasi tanaman obat pada masyarakat	Perbandingan preferensi masyarakat terhadap obat tradisional dan obat konvensional	Pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dalam penggunaan CAMT	Studi tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer di fasilitas pelayanan kesehatan	Studi Penyusunan modul penggunaan CAMT/Therapy modelling CAMT	Modul penggunaan CAMT/ <i>Therapy modelling CAMT</i>
Survei pengetahuan dan pengalaman swamedikasi obat tradisional pada masyarakat	Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan/penggunaan obat tradisional CAMT		Studi perbandingan terapi komplementer dan terapi modalitas terhadap keberhasilan terapi penyakit degeneratif di pelayanan kesehatan		

Roadmap Penelitian Program Studi Teknologi Laboratorium Medik Tahun 2021-2025

Roadmap Grand Design Research Departemen Mikrobiologi (Media Alternatif Untuk Pertumbuhan Bakteri dan

Tahap 1 (2021)	Tahap 2 (2021-2022)	Tahap 3 (2022-2023)	Tahap 4 (2023-2024)	Tahap 5 (2024-2025)	Tahap 6 (2026)
Identifikasi Bahan Alami	Pembandingan media standar	Pembandingan media standar alami dan ekstraksi	Pembuatan bahan alami menjadi media kemasan	Pembandingan media standar dan media alami	Paten
- Identifikasi bahan alami untuk pembuatan media alternatif pertumbuhan bakteri dan jamur - Identifikasi bahan alami sebagai antibakteri dan antijamur	- Pembuatan media alternatif dari bahan alami untuk pertumbuhan bakteri dan jamur - Membandingkan media standar dan media alternatif	- Ekstraksi kandungan pada bahan pembuatan media alternatif - Pembuatan media alternatif dengan bahan yang sudah diekstraksi - Pembandingan hasil pertumbuhan bakteri dan jamur pada media	- Pembuatan bahan alami hasil uji coba menjadi media serbuk konvensional - Uji coba media alami dalam bentuk konvensional	Membandingkan media standar dan media alami dalam bentuk konvensional yang sudah diproduksi secara pabrik	Memberikan hak paten pada media alami konvensional

Roadmap Grand Design Research Departemen Mikrobiologi (Bahan Alami Sebagai Antibakteri dan

